



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Optimal

ASUHAN KEBIDANAN REMAJA

Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.
Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes
Syahridayanti, S. ST., M. Kes
Agustina, S.SiT., MKM
Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.SiT., M.Kes
Lusi Afriyani, S.S.T., M.Tr.Keb.
Machria Rachman, SST., M.Kes



ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA

Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.

Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes

Syahridayanti, S. ST., M. Kes

Agustina, S.SiT., MKM

Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.SiT., M.Kes

Lusi Afriyani, S.S.T., M.Tr.Keb.

Machria Rachman, SST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEBIDANAN PADA REMAJA

Penulis:

Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.
Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes
Syahridayanti, S. ST., M. Kes
Agustina, S.SiT., MKM
Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.SiT., M.Kes
Lusi Afriyani, S.S.T., M.Tr.Keb.
Machria Rachman, SST., M.Kes

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Achmad Faisal

ISBN:

978-623-88659-2-5

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Masa remaja adalah masa transisi kehidupan menuju dewasa, perlunya asuhan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan remaja supaya dapat memberdayakan diri dengan baik. Saat ini, media informasi yang mudah diakses oleh remaja tanpa pengawasan orang tua maupun orang yang kompeten terhadap kesehatan remaja, akan membuat remaja mendapatkan informasi yang tidak tepat untuk menunjang proses tumbuh kembang remaja. Hal tersebut memacu penulis untuk berkontribusi dalam buku berbasis bukti ini, sebagai upaya memberikan informasi yang tepat bagi para remaja beserta orang tua, tenaga kesehatan atau pendamping remaja serta masyarakat luas.

Kami haturkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan buku ini, para dosen pecinta literasi dari Sabang hingga Marauke, sehingga buku ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Harapan penulis, semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan remaja baik bagi remaja itu sendiri, orang tua, keluarga, tenaga medis dan masyarakat pada umumnya. Permohonan maaf penulis sampaikan atas kekurangan yang terdapat pada buku ini, semoga dapat menjadi pemacu kami menulis dengan lebih baik pada buku kami berikutnya.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I EFEK STUNTING PADA REMAJA.....	1
BAB II ANAMNESIS DENGAN PENDEKATAN METODE HEEADSSS	15
BAB III PSIKOLOGI REMAJA	27
BAB IV PERSONAL HYGIENE PADA REMAJA	37
BAB V ANEMIA PADA REMAJA PUTRI	49
BAB VI SENAM DISMENOREA	59
BAB VII PREVENSI PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA REMAJA MELALUI PENDIDIKAN SEKSUALITAS KOMPREHENSIF (CURRICULUM SEXUALITY EDUCATION)	83

BAB I

EFEK STUNTING PADA REMAJA

Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

EFEK STUNTING PADA REMAJA

Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Terjadinya stunting pada anak merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama (Kemenkes RI, 2022a). Kurang lebih 5 juta anak Indonesia, 1 dari 4 mengalami stunting. Angka stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 24%. Bayi lahir stunting di Indonesia mencapai 23%, oleh karena itu baiknya intervensi pencegahan dapat dimulai sebelum bayi lahir dan semenjak perempuan masih remaja (BAPPENAS, 2022). Salah satu penyebab stunting saat bayi adalah wanita disaat remaja tidak mengkonsumsi tablet tambah darah dan berisiko anemia. Saat ini 8,3 juta dari 12,1 juta remaja putri tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada tahun 2024 Indonesia menargetkan angka stunting turun hingga 14% (Kemenkes RI, 2022a).

Risiko stunting pada remaja dapat berdampak pada masa depannya yaitu mengalami kemungkinan besar mengalami panggul sempit sehingga mengalami gangguan persalinan saat melahirkan (Sriwiyanti et al., 2022).

Pemerintah merencanakan 2 intervensi untuk menangani kasus stunting ini yaitu dua intervensi holistik dan satu intervensi sensitif. Intervensi spesifik yaitu intervensi yang dilakukan pada anak dalam waktu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada Ibu sebelum dan pada masa kehamilan. Intervensi sensitif dilakukan dalam bentuk kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor (Kemenkes RI, 2022b).

Sejalan dengan tujuan tersebut pemerintah telah menuangkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan atau pasangan usia subur pada masa sebelum hamil, serta menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas (Kemenkes RI, 2021).

B. Definisi Stunting

Stunting diartikan sebagai perawakan pendek akibat malnutrisi yang lama sehingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada anak dimana bila tinggi badan dan usia mereka lebih dari dua standar deviasi di bawah median Standar Pertumbuhan Anak WHO sesuai usia dan jenis kelamin (WHO, 2018).

Stunting dapat terjadi dalam 1000 hari pertama setelah pembuahan dan berhubungan dengan banyak faktor, termasuk sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, kekurangan zat gizi mikro dan kurangnya stimulasi psikososial (WHO, 2018).

Stunting adalah bentuk kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan pertumbuhan dimana terjadi dalam jangka waktu lama terjadi bersamaan saat seorang anak tumbuh dengan makanan dan layanan perawatan kesehatan yang tidak memadai. Stunting sering mengakibatkan gangguan kognitif termasuk keterlambatan perkembangan motorik, gangguan proses berpikir dan kegagalan dalam prestasi sekolah (Abate et al., 2020).

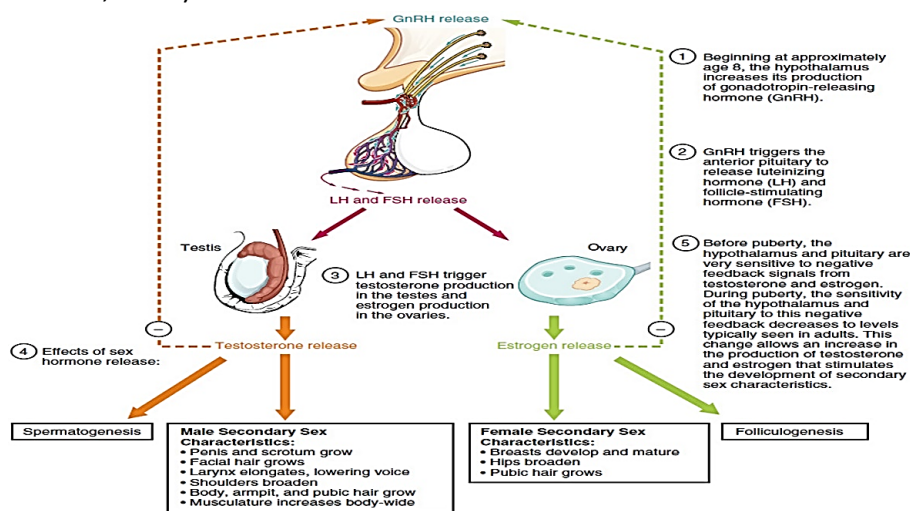
C. Definisi Remaja

Remaja menurut WHO merupakan tahap peralihan kehidupan manusia antara masa kanak-kanak menuju dewasa dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun (WHO, 2021). Definisi remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak adalah kelompok umur dengan rentang usia 10-18 tahun (Kemenkes RI, 2014).

BKKBN mendefinisikan remaja adalah kelompok umur yang berkisar antara 10-24 tahun dan belum menikah (BKKBN, 2021).

D. Fisiologi Pertumbuhan

Remaja mengalami perkembangan fisik, psiko-sosial dan kognitif yang pesat. Masa remaja terdiri dari dua tahap yaitu remaja awal usia 10-14 tahun dan remaja akhir 15-19 tahun (Abate et al., 2020). Masa remaja juga merupakan suatu proses perubahan fisiologis dan sosial seorang anak menjadi dewasa (Christian & Smith, 2018). Masa remaja adalah tahap perkembangan manusia, dan merupakan suatu periode pematangan sosioseksual, dimana remaja akan mulai memperlihatkan minat, aktifitas kehidupan sosial, ekonomi, dan seksual mereka (Scheffler & Hermanussen, 2018).



Gambar 1.1 Fisiologi Pubertas
(Health Jade, 2019)

Pubertas adalah proses perubahan fisik dimana remaja mencapai kematangan seksual dan sudah mampu untuk bereproduksi. Pubertas ditandai dengan adanya proses gonadotrofik dan somatotrofik. Proses gonadotrofik ditandai dengan terjadinya pematangan seksual yaitu ovulasi dan spermatogenesis, sedangkan proses somatotrofik bertanggung jawab terhadap terjadinya percepatan pertumbuhan linier dan perubahan kurus, gemuk, dan jaringan tulang. Pertumbuhan dan pematangan proses somatotrofik dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor yaitu hormonal, lingkungan (nutrisi merupakan peran penting) dan genetic (Christian & Smith, 2018).

Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia diperankan oleh kelenjar yang disekresikan dari Kelenjar Endokrin yaitu Kelenjar Hipofisis. Suplai darah yang kaya dalam infundibulum, membawa hormon pengatur dari Hipotalamus menuju Kelenjar Hipofisis lobus anterior, atau adenohipofisis, kemudian melepaskan hormon utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu hormon pertumbuhan (*Growth Hormone/GH*), hormon perangsang tiroid (*Thyroid Stimulating Hormone (TSH)*), Prolaktin, Gonadotrofin (*Luteinizing dan FSH*), dan Hormon Adrenocorticotropik (*ACTH*) (Candra, 2020).

Pertumbuhan normal akan terjadi apabila terjadi keselarasan fungsi antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hormon seringkali membutuhkan kolaborasi atau intervensi hormon lain untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Hormon pertumbuhan melepaskan faktor pertumbuhan seperti Hormon Insulin dari hati yaitu *IGF-1 (Insulin like Growth Factor 1)*. IGF-1 secara langsung memengaruhi serat otot rangka dan sel-sel tulang rawan di tulang panjang untuk meningkatkan tingkat penyerapan asam amino dan memasukkannya ke dalam protein baru, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan linear selama masa bayi dan masa anak-anak. Memasuki masa remaja, percepatan pertumbuhan remaja terjadi karena adanya kolaborasi hormon gonad, yaitu Testosteron pada anak laki-laki dan Estrogen pada anak perempuan. Terdapat penelitian yang menjelaskan tentang anak-anak dengan perawakan pendek yang tidak normal terjadi akibat faktor lingkungan yang mengganggu sistem endokrin menyebabkan gangguan pelepasan hormon pertumbuhan (Candra, 2020).

Paparan di atas menjelaskan bahwa malnutrisi menyebabkan stunting, tetapi stunting tidak selalu malnutrisi. Tenaga kesehatan baiknya melakukan pengukuran tinggi badan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar secara berkala dan kontinyu untuk menilai apakah seorang anak tumbuh normal atau terganggu. Gangguan pertumbuhan dapat diketahui apakah patologis atau tidak sehingga dapat ditentukan langkah lanjutan yang diperlukan karena tidak semua perawakan pendek memerlukan terapi dan rujukan (Tjahjono et al., 2017).

E. Klasifikasi Perawakan Pendek

Klasifikasi penyebab perawakan pendek adalah dapat dikarenakan kondisi patologis dan nonpatologis. Pendekatan klinis pada kasus-kasus perawakan pendek penting sekali dilakukan oleh tenaga kesehatan (Tjahjono et al., 2017).

Perawakan pendek yang paling banyak terjadi adalah stunting. Stunting dikorelasikan dengan malnutrisi dan infeksi kronis (nonendokrin). Sehingga perlu dijelaskan kembali bahwa stunting merupakan bagian dari perawakan pendek namun, tidak semua perawakan pendek adalah stunting (Tjahjono et al., 2017).

Tabel 1.1 Etiologi Perawakan Pendek

Varian Normal	Patologis
Perawakan pendek familial (Familial short stature)	Proporsional
Constitutional Delay of Growth and Puberty (CDGP)	Hormonal (BB/TB meningkat): Defisiensi hormon pertumbuhan, hipotiroid, sindrom Cushing, hipoparatiroid, dan lain-lain Non hormonal (BB/TB menurun): Malnutrisi, penyakit infeksi kronis, psikososial dwarfism, dan lain-lain
	Disproporsional
	Kelainan skeletal seperti akondroplasia, hipokondroplasia, rickets, osteogenesis imperfecta, dan lain-lain
	Dismorfik
	Sindrom Turner, sindrom Prader Willi, sindrom Noonan, sindrom Russel-Silver, sindrom Down, dan lain-lain
	Kelainan metabolik bawaan: Mucopolysaccharidosis (MPS), dan lain-lain

Sumber: Panduan Praktik Klinis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2017).

F. Etiologi Stunting pada Remaja

1. Pengaruh Growth Hormone

Peningkatan GH pada anak perempuan terjadi pada awal pubertas sedangkan pada anak laki-laki peningkatan ini terjadi pada akhir pubertas. Perbedaan ini menjelaskan mengapa terjadinya perbedaan tinggi akhir anak laki-laki dan perempuan. Tinggi badan anak laki-laki bertambah kira-kira 10 cm pertahun, sedangkan pada perempuan kurang lebih 9 cm pertahun. Secara keseluruhan pertambahan tinggi badan sekitar 25 cm pada anak perempuan dan 28 cm pada anak laki-laki. Pertambahan tinggi badan terjadi dua tahun lebih awal pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Puncak pertumbuhan tinggi badan (*peak height velocity*) pada anak perempuan terjadi sekitar usia 12 tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada usia 14 tahun. Pada anak perempuan, pertumbuhan akan berakhir pada usia 16 tahun sedangkan pada anak laki-laki pada usia 18 tahun. Setelah usia tersebut, pada umumnya pertambahan tinggi badan hampir selesai. Hormon steroid seks juga berpengaruh terhadap maturasi tulang pada lempeng epifisis. Pada akhir pubertas lempeng epifisis akan menutup dan pertumbuhan tinggi badan akan berhenti (Batubara, 2010).

Percepatan pertumbuhan tinggi badan bisa lambat atau tertunda pada perempuan yang sangat membatasi asupan kalori. Pertambahan tinggi badan pada perempuan yang mengalami prekoks (menarche pada usia 6, 5 tahun), akan

dimulai lebih dulu namun berhenti lebih cepat sehingga akan menjadi lebih pendek saat dewasa. Awitan pubertas dan pertumbuhan tinggi badan baik pada remaja laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, nutrisi, lingkungan, dan sosial ekonomi sehingga awal tanda pubertas timbul bervariasi (Suryansyah, 2012).

2. Asupan Zink

Asupan zink berkaitan secara signifikan dengan kejadian stunting pada remaja. Zink merupakan salah satu mikronutrien yang memiliki struktur pada beberapa sistem enzim yang terlibat dalam pertumbuhan fisik, imunologi dan fungsi reproduksi. Zink berkaitan dengan hormon-hormon penting dalam pertumbuhan tulang seperti samatomedin-c, osteocalcin, testosteron, hormon tiroid dan insulin. Zink juga membantu penyerapan vitamin D terhadap metabolisme tulang dengan stimulasi sintesis DNA di sel-sel tulang. Penjelasan tersebut menjelaskan zink erat kaitannya dengan metabolisme tulang, sehingga sangat penting dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Defisiensi zink menyebabkan gangguan pada metabolisme dan fungsi tubuh diantaranya adalah terjadinya gangguan pertumbuhan, peningkatan infeksi, dan munculnya lesi pada kulit dan menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan pertumbuhan, stunting, dan wasting (Alwi et al., 2022; King et al., 2016).

Studi yang menjelaskan keterkaitan antara asupan zink dan stunting masih terbatas karena perlu adanya informasi terkait konsentrasi serum untuk menilai status kecukupan asupan zink, waktu reabsorpsi zink yang tepat, jarak waktu antara darah pengumpulan dan sentrifugasi, adanya bias sistemik peradangan dan pemberian suplemen atau obat lain perlu diperhatikan (Irawati et al., 2021; King et al., 2016).

3. Asupan Protein

Hasil studi di India menjelaskan stunting yang terjadi pada remaja laki-laki signifikan dengan asupan protein yang kurang dibandingkan remaja laki-laki dengan kondisi pertumbuhan yang normal. Molekul-molekul protein terdapat pada enzim, hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler dan sebagainya. Asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai prekursor sebagian besar koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial untuk kehidupan sehingga berfungsi untuk membangun, memelihara sel-sel dan jaringan tubuh serta pertumbuhan dan perbaikan sel – sel (Shafiee et al., 2015).

Kekurangan protein berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, konsumsi protein yang kurang dan kualitas protein yang tidak adekuat berkontribusi pada terjadinya kekurangan protein dan asam amino (Gat-yablonski & Phillip, 2015). Protein adalah elemen yang mengatur dan mempengaruhi fungsi DNA sebagai

pengontrol proses pertumbuhan dengan mengatur berbagai unsur yang ada didalamnya. Protein yang merupakan unsur dari IGF-1, sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis sebagai mediator kualitas hormon pertumbuhan. Protein yang inadekuat akan menghambat produksi IGF-1, sehingga merangsang osteoblas dan bila berlangsung dalam jangka waktu lama dan terus menerus akan menghambat proses pertumbuhan. Perlunya konsumsi protein yang adekuat sangat penting diberikan sejak balita dan tetap dikontrol pada saat remaja untuk mencegah terjadinya stunting (Alwi et al., 2022; Sari et al., 2016).

4. Infeksi karena Kecacingan

Soil-transmitted helminths (STHs) atau penularan cacing melalui tanah yaitu jenis *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan cacing tambang telah menginfeksi sekitar 1,5 miliar orang di seluruh dunia melalui kontaminasi tanah dengan telur dalam kotoran manusia. Malnutrisi dan infeksi memiliki keterkaitan dan merupakan termasuk pada masalah kesehatan masyarakat karena berdampak besar pada perkembangan anak, peningkatan risiko infeksi, berkurangnya kehadiran di sekolah, serta gangguan kognitif dan perkembangan fisik yang akan berdampak pada kehidupan dewasa mereka (Gasparinho et al., 2022).

Kecacingan yang sudah cukup lama dialami oleh anak menyebabkan defisiensi zat gizi penting yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak, hal ini terlihat dari kecenderungan anak yang mengalami infeksi kecacingan cenderung tinggi badannya pendek dan prevalensi anak bertubuh pendek mencapai 43,3% dan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka saat remaja (Salma et al., 2022). Cacingan berdampak pada penurunan asupan zat gizi semisal karbohidrat, protein dan kehilangan darah. Cacingan pada anak usia sekolah menyebabkan kondisi fisik yang lemah dan memiliki risiko yang tinggi untuk terinfeksi penyakit. Cacingan merupakan salah satu faktor penyebab stunting karena Anak yang positif menderita kecacingan tidak mengalami kenaikan berat badan atau berat badan rendah (Annisa et al., 2018).

Infeksi cacing yang berulang jika dialami pada anak bisa menyebabkan gangguan gizi dan berujung pada kegagalan pertumbuhan atau stunting (fisik anak menjadi lebih pendek dan kecil dari teman seusianya) (Annisa et al., 2018). Oleh karena itu perlunya pemberian terapi yang tepat pada anak dan remaja dengan kecacingan (Kemenkes RI, 2017).

G. Pendekatan Diagnosis

Evaluasi anak dengan short stature dibutuhkan pengukuran tinggi badan serial yang di plot pada kurva pertumbuhan, untuk menilai kecepatan pertumbuhan.

Kecepatan pertumbuhan secara ideal diperiksa dengan melihat beberapa titik pertumbuhan sebelumnya atau pengukuran ulang tiap 4-6 bulan (Imanuel, 2011).

Menurut IDAI (2017), pengambilan diagnosa anak dengan perawakan pendek terutama stunting diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kriteria awal mendiagnosis anak dengan perawakan pendek adalah:

1. Tinggi badan

Pemantauan tinggi badan dilakukan secara berkala dan kontinyu, sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tentang pemantauan tumbuh-kembang anak.

Tabel 1.2 Rekomendasi Jadwal Pemantauan Tinggi Badan

Usia	Jadwal pemantauan
0-12 bulan	Setiap 1 bulan
1-3 tahun	Setiap 3 bulan
3-6 tahun	Setiap 6 bulan
6-18 tahun	Setiap 1 tahun

Sumber: Panduan Praktik Klinis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2017).

2. Kecepatan pertumbuhan

Fase pertumbuhan terdiri atas empat fase yaitu intrauterin, bayi, anak, dan pubertas. Pola pertumbuhan spesifik pada masing-masing fase dan ada atau tidak adanya gangguan pertumbuhan seorang anak perlu dilakukan pemantauan pada masing-masing tahapan fase tersebut.

Tabel 1.3 Kecepatan Pertumbuhan

Usia	Kecepatan pertumbuhan (cm/tahun)
Intrauterin	60 - 100
0 - 12 bulan	23 - 27
1 - 2 tahun	10 - 14
2 - 5 tahun	6 - 7
Prapubertas	5 - 5,5
Pubertas	Perempuan : 8-12
	Laki-laki : 10-14

Sumber: Panduan Praktik Klinis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2017).

3. Perkiraan tinggi akhir

Perkiraan tinggi akhir berdasarkan mid-parental height dan potensi tinggi genetik perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi pola pertumbuhan dan deviasi dari tinggi yang diharapkan. Rumus perkiraan tinggi akhir tertera pada tabel dibawah ini:

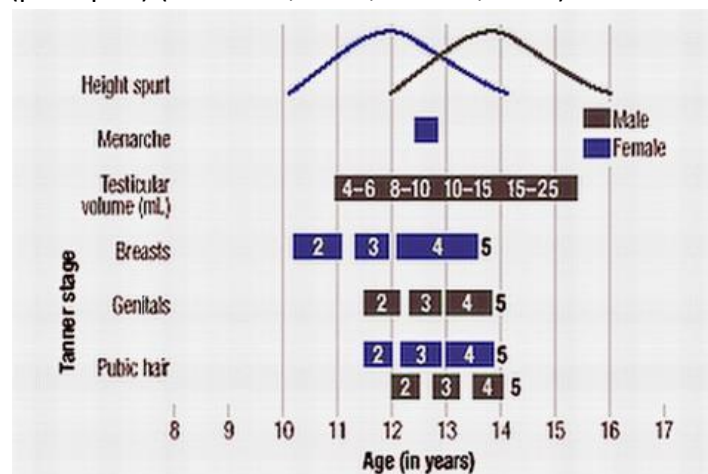
Tabel 1.4 Perhitungan Mid-Parental Height dan Potensi Tinggi Genetik

1. Mid-parental height:
Laki-laki = $\frac{[\text{tinggi badan Ayah (cm)}] + [\text{tinggi badan Ibu (cm)} + 13]}{2}$
Perempuan = $\frac{[\text{tinggi badan Ayah (cm)} - 13] + [\text{tinggi badan Ibu (cm)}]}{2}$
2. Potensi tinggi genetik:
Mid-parental height $\pm 8,5$ cm

Sumber: Panduan Praktik Klinis Ikatan Dokter Anak Indonesia (2017).

H. Pendekatan Diagnosa dengan Tanner Staging atau Sexual Maturation Rating (SMR)

Penilaian stunting pada remaja bukan hanya pada tinggi badan namun harus diiringi dengan pengamatan lainnya yaitu penilaian pada sistem hormonal seperti yang sudah dijelaskan pada proses fisiologis pertumbuhan dan perkembangan remaja serta pengamatan pada tanda-tanda seks sekunder. Tanner Staging atau *Sexual Maturation Rating (SMR)* adalah salah satu cara penilaian tumbuh kembang pada remaja dengan melakukan pengamatan pada tanda-tanda seks sekunder yaitu pertumbuhan rambut pubis, perkembangan payudara dan mulainya menstruasi (pada wanita) atau derajat perkembangan testis dan penis serta pertumbuhan rambut pubis (pada pria) (Brix et al., 2019; Candra, 2020).



Gambar 1.2 Tanner Stage
(Frida Soesanti, 2015)

Tabel 1.5 Tahap Perkembangan Pubertas Anak Laki-Laki Menurut Tanner

Tahap	Genitalia	Rambut pubis
Tahap 1	Prapubertas	Prapubertas; tidak ada rambut pubis
Tahap 2	Pertambahan volume testis, skrotum membesar, menipis dan kemerahan	Jarang, sedikit pigmentasi dan agak ikal, terutama pada pangkal penis
Tahap 3	Penis mulai membesar baik dalam panjang maupun diameter, volume testis dan skrotum terus bertambah membesar	Tebal, ikal, meluas hingga ke mons pubis
Tahap 4	Testis dan skrotum terus membesar, warna kulit skrotum yang makin gelap penis makin membesar baik panjang maupun diameter	Bentuk dewasa, tetapi belum meluas ke medial paha
Tahap 5	Bentuk dan ukuran dewasa	Bentuk dewasa, meluas ke medial pubis

(Batubara, 2010)

Tabel 1.6 Tahap Perkembangan Pubertas Anak Perempuan Menurut Tanner

Tahap	Payudara	Rambut pubis
Tahap 1	Prapubertas	Tidak ada rambut pubis
Tahap 2	Breast budding, menonjol seperti bukit kecil, areola melebar	Jarang, berpigmen sedikit, lurus, atas medial labia
Tahap 3	Payudara dan areola membesar, tidak ada kontur pemisah	Lebih hitam, mulai ikal, jumlah bertambah
Tahap 4	Areola dan papilla membentuk bukit kedua	Kasar, keriting, belum sebanyak dewasa
Tahap 5	Bentuk dewasa, papilla menonjol, areola sebagai bagian dari kontur buah dada	Bentuk segitiga seperti pada perempuan dewasa, tersebar sampai medial paha

(Batubara, 2010)

Tanner stage 1 menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan prepubertas, stage 2-5 menunjukkan progresivitas pubertas, stage 5 menunjukkan kematangan seksual sempurna. Tingkat kematangan seksual meningkat seiring dengan pertumbuhan, perubahan hormon, berat dan komposisi tubuh pada remaja (Brix et al., 2019; Christian & Smith, 2018).

Awal pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan meningkatnya volume testis yaitu lebih dari 3 mL dengan menggunakan alat orkidometer Prader. Pembesaran testis biasanya terjadi pada usia 9 tahun lalu diikuti dengan pembesaran penis. Pembesaran penis terjadi bersamaan dengan paku tumbuh. Ukuran penis dewasa dicapai pada usia 16-17 tahun. Rambut aksila akan tumbuh setelah rambut pubis mencapai P4, sedangkan kumis dan janggut tumbuh setelahnya. Rambut aksila bukan merupakan petanda pubertas yang pasti karena pengaruh dari berbagai faktor. Pertambahan panjang pita suara akibat pertumbuhan laring dan pengaruh testosteron menyebabkan terjadinya perubahan suara. Perubahan suara ini terjadi umumnya pada pertengahan pubertas bersamaan dengan pertumbuhan penis. Mimpi basah atau *wet dream* terjadi sekitar usia 13-17 tahun, bersamaan dengan puncak pertumbuhan tinggi badan (Batubara, 2010; Muliani et al., 2017).

Awal pubertas pada anak perempuan dimulai dari pertumbuhan payudara kemudian diikuti dengan percepatan pertumbuhan, rambut pubis dan axilla. Pertumbuhan ini umumnya terjadi saat usia 8 sampai 13 tahun (SMR stage 2) lalu 2 sampai 4 tahun sesudahnya akan mengalami menstruasi pertama (umumnya ketika SMR stage 4). Keterlambatan menarche dapat diakibatkan karena kurangnya asupan kalori dan berat badan. Lama perkembangan pubertas tergantung dari kadar sex steroid hormone pada awal pubertas, rata-rata terjadi selama 3–3,5 tahun pada perempuan namun dapat diselesaikan dalam waktu 2 atau bahkan lebih dari 5 sampai 6 tahun. Menarche terjadi kurang lebih 2,5 tahun setelah dimulainya perkembangan payudara. Siklus menstruasi selama 2 tahun setelah menarche

cenderung anovulatory sehingga siklus menjadi tidak teratur (Batubara, 2010; Muliani et al., 2017).

Dimulainya proses kematangan seksual berbeda antar ras dan budaya. Perempuan Afrika memulai proses lebih dahulu daripada perempuan Amerika namun prosesnya berjalan lebih lama. Hal ini terlihat dari usia menarche pada perempuan Afrika yang hampir sama dengan perempuan Amerika (Stang and Story, 2005).

Percepatan tinggi badan perempuan terjadi mulai SMR stage 2, sekitar umur 9,5 sampai 14,5 tahun (Stang and Story, 2005; Doyle, 2013). Puncak percepatan pertumbuhan adalah pada akhir stage 2 dan ketika stage 3, kurang lebih 6 sampai 12 bulan sebelum menarche (antara usia 11 sampai 13,5 tahun) (Stang and Story, 2005; Doyle, 2013). Diperkirakan 15 sampai 25 % tinggi dewasa sudah tercapai ketika pacu tumbuh saat pubertas.

Puncak percepatan pacu tumbuh pada laki-laki terjadi setelah perempuan, kurang lebih saat SMR stage 4, rata-rata sekitar usia 14,4 tahun. Pertumbuhan tersebut hampir bersamaan dengan perkembangan testis dan pertumbuhan rambut wajah (Stang and Story, 2005).

I. Asuhan Kebidanan yang dapat Diberikan

1. Suplementasi Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri
2. Pemberian obat cacing pada remaja putri
3. Promosi gizi seimbang
4. Pemberian suplementasi zink
5. Penyediaan akses PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) di Puskesmas
6. Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah
7. Pemberian edukasi gizi remaja
8. Pembentukan konselor sebaya untuk membahas seputar perkembangan remaja (Kemenkes RI, 2014, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Abate, B. B., Kassie, A. M., Zemariam, A. B., & Alamaw, A. W. (2020). Prevalence and Determinants of Stunting among Adolescent Girls in Ethiopia. *Journal of Pediatric Nursing*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.01.013>
- Alwi, M. A., Hamzah, H., & Lewa, A. F. (2022). Determinan dan Faktor Risiko Stunting pada Remaja di Indonesia : Literature Review. *SVASTA HARENA : JURNAL ILMIAH GIZI*, 3(Agustus), 7–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33860/shjig.v2i1>
- Annisa, S., Dalilah, Anwar, C., & Novrikasari. (2018). The Relationship Between Soil Transmitted Helminthes (STH) Infection and Nutritional Status in Students of State Elementary School Number (SDN) 200 Palembang Indonesia. *Bioscientia Medicina*, 2(2), 42–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.32539/bsm.v2i2.39>
- BAPPENAS. (2022). *Mengenal Studi Status Gizi Indonesia 2021*. <https://cegahstunting.id/berita/mengenal-studi-status-gizi-indonesia-2021/>
- Batubara, J. R. L. (2010). Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*, 12(1), 21–29.
- BKKBN. (2021). *Remaja Ideal Generasi Perubahan (Problematika, Perkembangan dan Potensi)*. <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=2127>
- Brix, N., Ernst, A., Lauridsen, L. L. B., Parner, E., Støvring, H., Olsen, J., Henriksen, T. B., & Ramlau-Hansen, C. H. (2019). Timing of Puberty in Boys and Girls : A Population-Based Study. *Paediatric and Perinatal Epidemiology Published*, 33(August 2018), 70–78. <https://doi.org/10.1111/ppe.12507>
- Candra, A. (2020). Patofisiologi Stunting. *Journal of Nutrition and Health*, 8(2), 74–78.
- Christian, P., & Smith, R. (2018). *Adolescent Undernutrition : Global Burden , Physiology , and Nutritional Risks*. 72, 316–328. <https://doi.org/10.1159/000488865>
- Frida Soesanti. (2015). *Kapan Anak Dikatakan Mengalami Pubertas?* IDAI. <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/kapan-anak-dikatakan-mengalami-pubertas>
- Gasparinho, C., Gonçalves, M. H., Silva, G. L., Fortes, F., & Gonçalves, L. (2022). Deworming with Albendazole or a Test-and-Treat Approach for Intestinal Parasites : Binary Longitudinal Models with Temporal Structure in a Four-Arm Randomized Trial. *Nutrients*, 14. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu14112185>
- Gat-yablonski, G., & Phillip, M. (2015). Nutritionally-Induced Catch-Up Growth. *Nutrients*, 517–551. <https://doi.org/10.3390/nu7010517>
- Health Jade. (2019). *Tanner scale*.
- Immanuel, S. (2011). Klasifikasi dan Diagnosis Laboratorium pada Short Stature. *Departemen Patologi Klinik FKUI–RSCM*.

- Irawati, D., Nurbaiti, L., & Ekawanti, A. (2021). Zinc Deficiency among Adolescence in Stunting Locus Area , Lombok , Indonesia. *2nd Global Health and Innovation in Conjunction with 6th ORL Head and Neck Oncology Conference (ORLHN 2021) Zinc*, 46, 301–307.
- Kemenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Kementerian Kesehatan RI*.
- Kemenkes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Cacingan*.
- Kemenkes RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (No. 21)*. Kemenkes RI : Jakarta.
- Kemenkes RI. (2022a). *Cegah Stunting Itu Penting*. Kemenkes RI. <https://promkes.kemkes.go.id/cegah-stunting-itu-penting>
- Kemenkes RI. (2022b). *Upaya Intervensi Spesifik Kementerian Kesehatan untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen Tahun 2024*. Kemenkes RI. <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/upaya-intervensi-spesifik-kementerian-kesehatan-untuk-capai-target-prevalensi-stunting-14-persen-tahun-2024>
- King, J. C., Brown, K. H., Gibson, R. S., Krebs, N. F., Lowe, N. M., Siekmann, J. H., & Raiten, D. J. (2016). Biomarkers of Nutrition for Development (BOND)—Zinc Review1–5. *The Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.3945/jn.115.220079>
- Muliani, Widiyanti, I. G. A., Wardana, N. G., Yuliana, & Karmaya, M. (2017). Tahap pertumbuhan dan perkembangan tanda-tanda seks sekunder remaja SMPN 4 Bangli ,. *Medicina*, 48(2), 75–82. <https://doi.org/10.15562/medi.v48i2.31>
- Salma, W. O., Alifariki, L. O., & Siagian, H. J. (2022). Study Retrospektif Kejadian Stunting pada Balita. *Health Care : Jurnal Kesehatan*, 11(1), 215–224.
- Sari, E. M., Juffrie, M., Nurani, N., & Sitaresmi, M. N. (2016). Asupan protein , kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 12(4).
- Scheffler, C., & Hermanussen, M. (2018). Growth in Childhood and Adolescence. *The International Encyclopedia Of Biological Anthropology*. <https://doi.org/10.1002/9781118584538.ieba0537>
- Shafiee, S., Mesgarani, M., & Begum, K. (2015). Assessment of Nutritional Status Among Adolescent Boys in an Urban Population of South India. *Global Journal of Health Science*, 7(3), 335–344. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v7n3p335>
- Sriwiyanti, Hartati, S., & Nazarena, Y. (2022). *Panduan Sederhana Pencegahan Resiko Stunting Bagi Remaja Putri* (Penerbit Lembaga Omega Medika (ed.); 1st ed.).

Lembaga Omega Medika.

Suryansyah, A. (2012). Gambaran Tanda Pubertas pada Murid Sekolah Dasar. *Sari Pediatri*, 13(5).

Tjahjono, H. A., Aditiawati, Pulungan, A. B., Marzuki, A. N. S., Rini, E. A., Himawan, I. W., & Batubara, J. R. (2017). *Perawakan Pendek pada Anak dan Remaja di Indonesia*. IDAI.

WHO. (2018). Reducing Stunting In Children. In *Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260202/9789241513647-eng.pdf?sequence=1>

WHO. (2021). *Adolescent health*. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

BAB II

ANAMNESIS DENGAN PENDEKATAN METODE HEEADSSS

Devi Endah Saraswati,S.ST.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ANAMNESIS DENGAN PENDEKATAN METODE HEEADSSS

Devi Endah Saraswati,S.ST.,M.Kes

A. Abstrak

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat tersebut diiringi dengan adanya masalah atau resiko kesehatan yang terjadi. Masalah remaja yang dapat menimbulkan resiko kesehatan sering tidak diungkapkan secara baik oleh remaja karena adanya perasaan malu atau merasa akan ada pandangan negatif terhadap dirinya. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah menyusun panduan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR) yang berisi Langkah-langkah dan acuan dalam melaksanakan asuhan pada remaja. Dalam MTPKR terdapat pendekatan anamnesis dengan metode HEEADSS yang dengan menggunakan metode tersebut dapat mengetahui permasalahan remaja yang mungkin saat ini tersembunyi atau tidak diungkapkan oleh remaja tersebut. Dengan adanya MTPKR dan metode anamnesis pendekatan HEEADSSS diharapkan dapat menggali permasalahan remaja yang tidak terungkap yang dapat mempengaruhi keadaan kesehatan, sehingga dapat dilakukan penanganan segera dan kesehatan remaja akan terjaga.

Kata Kunci: remaja, MTPKR, HEEADSSS

B. Pendahuluan

Remaja saat ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan global (Anisah 2020). Masa remaja merupakan masa yang penting karena merupakan masa peralihan dari anak – anak menuju dewasa yang menuntut tanggung jawab atas dirinya (Kusmiran 2011). Pada saat ini permasalahan yang dialami oleh remaja sangat kompleks yaitu gizi, kesehatan reproduksi, pernikahan usia muda, penyalagunaan obat terlarang, kekerasan dan pelecehan seksual, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan mental dan resiko cedera (Azzopardi et al 2019).

Banyaknya masalah yang dialami oleh remaja maka diperlukan pembinaan kesehatan remaja dan dijadikan sebagai prioritas program pemerintah (Anisah 2020). Upaya pemerintah dalam penanganan masalah remaja adalah dengan membuat kebijakan kesehatan remaja yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan asuhan kepada remaja. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memuat upaya pencegahan, pemeliharaan, pengobatan, pemulihan dan perlindungan (Dachi 2017).

Dalam upaya mendeteksi masalah yang dialami oleh remaja kita dapat menggunakan panduan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja. Dalam Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja terdapat suatu metode

anamnesis HEEADSSS yang dapat menggali masalah remaja yang mungkin tersembunyi atau enggan diungkapkan oleh remaja yang dapat memberikan resiko terhadap kondisi kesehatannya.

C. Pembahasan

1. Remaja

a. Definisi

Remaja adalah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Sofia and Adiyanti 2013).

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun (WHO 2014). Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun (Kemenkes 2020). Remaja adalah penduduk dengan rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (BKKBN 2011)

b. Tahap perkembangan remaja

Ada beberapa fase perkembangan pada remaja yaitu:

1) Pra Remaja

Fase ini adalah remaja dengan usia 11 atau 12 tahun sampai 14 tahun. Fase ini sangat pendek dan remaja akan sangat tertutup dengan orang tua dan orang sekitar. Remaja akan mengalami perubahan bentuk tubuh dan hormonal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi remaja.

2) Remaja Awal

Fase ini adalah remaja dengan usia 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Merupakan fase dimana banyak perubahan yang terjadi dalam diri remaja. Di fase ini remaja mulai mencari jati diri, dan mulai mandiri dengan keputusan yang mereka ambil. Pemikiran remaja semakin logis, dan semakin banyak waktu untuk membicarakan keinginan dengan orang tua.

3) Remaja lanjut (17 sampai 20 atau 21 tahun)

Pada fase ini remaja ingin menonjolkan diri, mereka ingin menjadi pusat perhatian. Sudah memiliki cita-cita yang jelas, lebih bersemangat, sudah mulai menetapkan identitas diri dan tidak bergantung pada kondisi emosional (Diananda 2018).

c. Masalah Kesehatan Remaja

Masalah kesehatan remaja saat ini adalah masalah gizi (gizi kurang, gizi lebih, postur pendek, anemia), kurang konsumsi protein dan kalori, kurang konsumsi serat, kurang aktifitas fisik, adanya perilaku beresiko seperti: merokok, minuman beralkohol, NAPZA, seks pra nikah, masalah kehamilan, penyakit

infeksi (IMS, ISPA, HIV/ AIDS dan Diare), penyakit metabolik seperti diabetes, gangguan emosional serta kecelakaan berkendara (BKKBN 2012).

2. Anamnesis Dengan Pendekatan Metode HEEADSSS

Anamnesis dengan pendekatan metode Heeadsss merupakan bagian dari Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR).

a. MTPKR

MTPKR merupakan panduan rujukan praktis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada remaja. Panduan ini untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan primer pada remaja. Pada MTPKR terdapat alur yang merupakan tahapan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan

Petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan adalah Dokter, Bidan atau Perawat.

1) Alur MTPKR

Pertama dimulai dari keluhan yang disampaikan remaja, kemudian pilih satu algoritma yang sesuai dengan keluhan tersebut. Selanjutnya “tanya, lihat/ rasa/ dengar” agar dapat menentukan klasifikasi secara tepat sesuai dengan kondisi remaja.

MTPKR tidak memuat panduan klinis semua penyakit, apabila ada keluhan penyakit yang tidak terdapat pada panduan MTPKR maka remaja dirujuk ke fasilitas kesehatan primer

Setelah selesai dengan algoritma lanjutkan dengan anamnesis dengan pendekatan HEEADSSS untuk menggali aspek psikososial yang sering tidak diungkapkan oleh remaja jika tidak ditanyakan oleh petugas kesehatan.

Hasil dari anamnesis HEEADSSS petugas kesehatan dapat memilih satu atau lebih algoritma yang lain, kemudian telusuri algoritma tersebut untuk menentukan klasifikasi yang tepat sesuai kondisi pada remaja.

a) Algoritma pada MTPKR meliputi:

- Algoritma Pertumbuhan dan Perkembangan
Pada algoritma pertumbuhan dan perkembangan hal yang dikaji meliputi: gizi kurang/ gizi lebih, postur pendek, pubertas dan anemia
- Algoritma Kesehatan Reproduksi
Pada algoritma kesehatan reproduksi hal yang dikaji meliputi: masalah menstruasi, masalah terkait kehamilan, dan infeksi menular seksual.
- Algoritma Genitalia

Algoritma genetalia mengkaji masalah alat kelamin khususnya pada remaja laki-laki.

- Algoritma Infeksi

Algoritma infeksi yang dikaji meliputi: infeksi HIV/ AIDS, infeksi malaria dan infeksi tuberculosis

- Algoritma Kesehatan Jiwa

Algoritma kesehatan jiwa yang dikaji meliputi: masalah kekerasan pada remaja, gangguan mental emosional, masalah rokok, alkohol, narkoba dan obat-obatan terlarang

- Algoritma Indera

Algoritma indera yang dikaji meliputi: masalah kulit, masalah THT, masalah ketajaman penglihatan

- Algoritma Lain-lain.

Algoritma lain-lain yang dikaji meliputi: nyeri kepala, nyeri perut non menstruasi, dan kekerasan (Kemenkes 2019).

b) Arti Warna Yang Ada Pada Algoritma.

Dalam algoritma, terdapat pembagian klasifikasi dalam warna yaitu warna merah, kuning, dan hijau dengan arti sebagai berikut:

- Merah

Kondisi gawat darurat, harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)

- Kuning

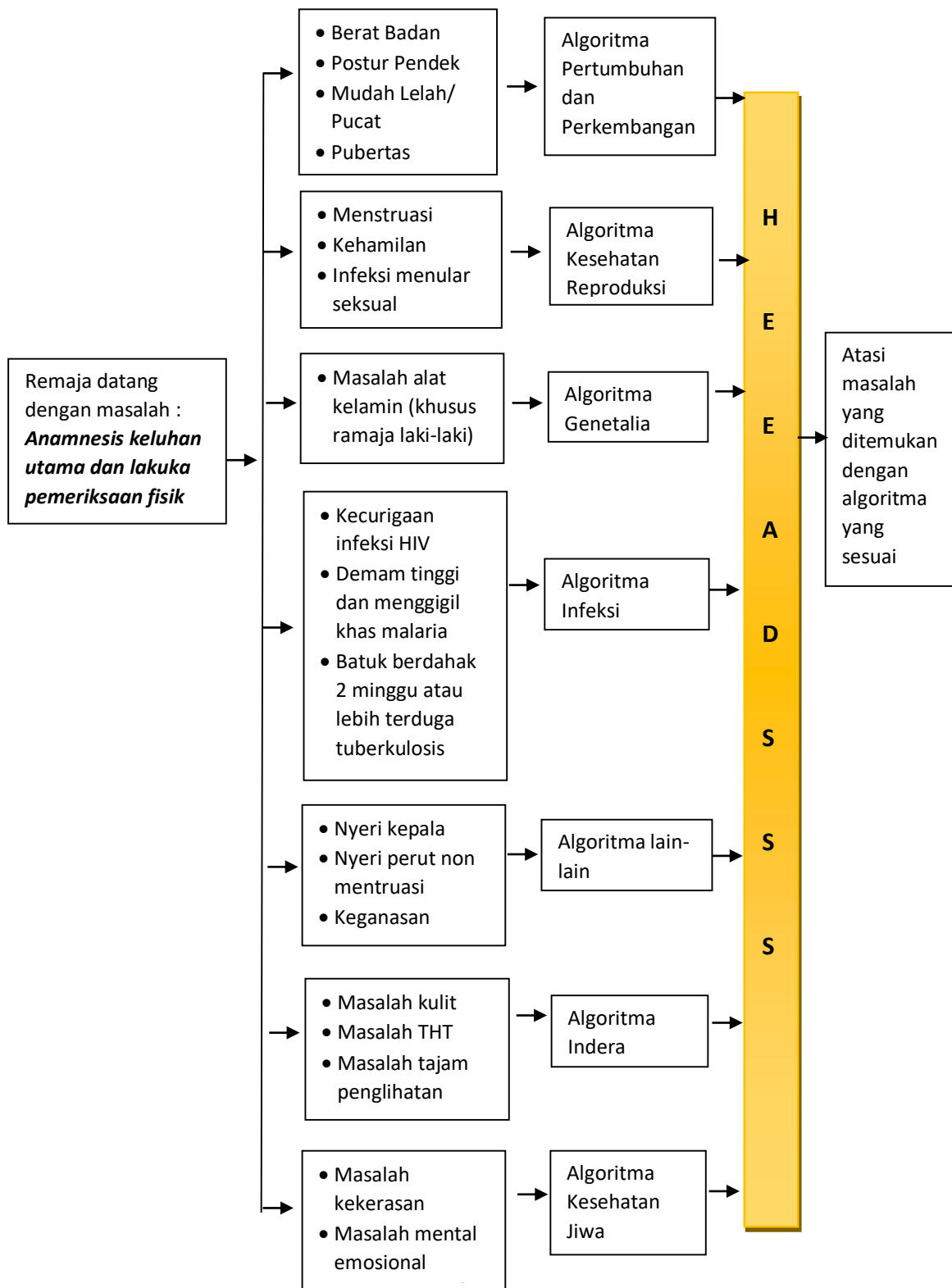
Masalah dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan di tingkat pertama dengan observasi dan/atau tindak lanjut

- Hijau

Kondisi normal atau masalah dapat diselesaikan secara tuntas di fasilitas kesehatan di tingkat pertama (Kemenkes 2014).

Dalam menggunakan algoritma perlu adanya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang diberikan kepada keluarga terdekat seperti ayah/ ibu atau saudara kandung yang telah dewasa untuk melindungi hak pasien. Sebelum persetujuan tindakan medis remaja dan keluarga terlebih dahulu diberikan penjelasan secara menyeluruh, sehingga keluarga dapat mengambil keputusan saat kondisi emergensi yang memerlukan tindakan medis segera.

Alur MTPKR dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: (Kemenkes 2019)

2) Interaksi Klinis Petugas Kesehatan dengan Klien Remaja

Dalam melakukan interaksi dengan remaja petugas kesehatan harus membina hubungan baik dengan remaja, agar remaja nyaman dan terciptanya hubungan saling percaya.

Peran petugas kesehatan dalam Interaksi Klinis adalah:

- a) Memberikan informasi, nasehat, konseling dan pelajaran kesehatan remaja yang bertujuan agar perilaku remaja yang beresiko yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dapat dirubah dan perilaku yang baik dipertahankan.
- b) Mendeteksi/ mendiagnosisi dan mengobati gangguan kesehatan dan jika diperlukan maka dilakukan rujukan di fasilitas rujukan.
- c) Membantu memimpin anggota masyarakat untuk memahami kebutuhan remaja sehingga terbentuknya *agent of change* dalam memenuhi kebutuhan kesehatan (Kemenkes 2019).

b. Pendekatan Metode HEEADSSS

Pendekatan metode HEEADSSS digunakan untuk mendeteksi masalah yang sering dialami oleh remaja, dan masalah tersebut tidak dapat diungkapkan oleh remaja dengan baik jika tidak dikaji atau digali dengan baik.

Metode HEEADSSS dapat digunakan sebagai panduan tenaga kesehatan untuk menggali aspek – aspek penting yang dapat mengakibatkan masalah psikososial pada remaja.

Sebelum mengaplikasikan metode HEEADSSS maka perlu dibina hubungan yang baik dan saling percaya dengan remaja dan dilanjutkan dengan bertanya, menjamin kerahasiaan dari informasi yang didapat dan melakukan kolaborasi jika diperlukan.

Metode HEEADSSS ini dapat memberikan informasi mengenai fungsi remaja di beberapa bidang seperti:

H-Home

E-Education & Employment

E-Eating & Exercise

A-Activities & Peer Relationships

D-Drug use/Cigarettes/ Alcohol

S-Sexuality

S-Suicide and Depression

S-Safety

1) Tujuan Metode HEEADSSS.

- a) Mendapat laporan perkembangan seorang remaja
- b) Skrining risiko gangguan perilaku
- c) Mengidentifikasi kekuatan seorang remaja dan faktor proteksinya

d) Mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi dan prevensi

2) Penilaian HEEADSSS

Tidak semua masalah pada remaja yang ditemukan dapat diselesaikan pada satu waktu kunjungan. Saat melakukan kunjungan petugas kesehatan harus mengidentifikasi dan memilih untuk menatalaksana kasus potensial yang jika diperhitungkan membawa risiko kesehatan yang lebih besar pada remaja tersebut.

Dalam melakukan pengkajian petugas kesehatan memprioritaskan bagian-bagian yang paling berhubungan dengan:

a) Keluhan yang disampaikan

Misalnya:

- 1) Seorang remaja datang dengan keluhan cedera jatuh dari sepeda motor setelah minum minuman beralkohol, maka pada penilaian HEEADSSS memprioritaskan bagian “obat-obatan”
- 2) Gangguan kesehatan potensial di daerah tempat bekerja:
Apabila tempat kerja anda berada di daerah dengan prevalensi HIV yang tinggi, maka prioritas pada penilaian HEEADSSS adalah “aktivitas seksual”.

Petugas harus memberikan kenyamanan dan menumbuhkan rasa percaya diri pada remaja karena dalam satu kali kunjungan mungkin hanya dapat melakukan penatalaksanaan 2 masalah karena adanya keterbatasan waktu. Dengan adanya kenyamanan dan rasa percaya diri maka remaja akan memiliki keinginan untuk kembali ke fasilitas kesehatan (puskesmas) untuk melakukan *follow up* atau mengatasi masalah lain yang dimiliki.

b) *Home* (Rumah/Tempat Tinggal)

Pada bagian ‘*Home*’ petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah di dalam rumah.

Hal yang perlu digali adalah :

- 1) Tingkat kenyamanan di rumah/tempat tinggal
- 2) Adanya dukungan keluarga di rumah/ tempat tinggal.
Di rumah/ tempat tinggal remaja merasa aman, jika terdapat masalah dapat berbicara secara terbuka dan meminta tolong kepada anggota rumah/ tempat tinggal
- 3) Kejadian yang terjadi di rumah yang dapat berpotensi menjadi ‘warisan’ perilaku beresiko pada remaja, seperti kekerasan, penggunaan alkohol dan penggunaan obat terlarang, dan seksualitas.

c) *Education/Employment* (Pendidikan/ Pekerjaan)

Pada bagian '*Education/Employment*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait pendidikan atau pekerjaan.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Tingkat kenyamanan di sekolah/tempat kerja
- 2) Adanya dukungan masyarakat di sekolah/ tempat kerja (remaja merasa aman, bisa bicara secara terbuka serta meminta tolong pada orang lain di sekolah/tempat kerja)
- 3) Perilaku beresiko yang terjadi di sekolah/tempat kerja yang bisa menjadi "warisan" perilaku seperti adanya kekerasan, penggunaan alkohol dan penggunaan obat terlarang, dan seksualitas
- 4) Perilaku intimidasi di lingkungan sekolah/ tempat kerja baik berupa intimidasi fisik maupun psikis dari teman / rekan kerja (*bullying*)

d) *Eating* (Pola Makan)

Pada bagian '*Eating*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait kebiasaan/pola makan.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Kebiasaan pola makan, jenis makanan yang dikonsumsi dan perilaku makan remaja saat mengalami stress
- 2) Perubahan berat badan yang dialami baik peningkatan ataupun penurunan berat badan.
- 3) Tanggapan/ penerimaan remaja terhadap tubuhnya.

e) *Activity* (Kegiatan/ Aktivitas)

Pada bagian '*Activity*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait aktivitas/ kegiatan yang dilakukan sehari-hari.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Kegiatan yang dilakukan remaja untuk menghabiskan waktu luangnya
- 2) Hubungan remaja dengan temannya baik teman dekat atau teman sebaya
- 3) Tanggapan/ penerimaan remaja terhadap dirinya dan teman-teman

f) *Drugs/ Obat* – obatan (NAPZA)

Pada bagian '*Drugs*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait risiko penyalahgunaan NAPZA.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Adanya lingkungan di sekitar remaja yang mengonsumsi NAPZA
- 2) Perilaku konsumsi NAPZA pada remaja
- 3) Perilaku konsumsi obat-obat pelangsing pada remaja

g) *Sexuality* (Aktivitas Seksual)

Pada bagian '*Sexuality*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait aktivitas seksual.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Adanya perilaku seksual pra nikah atau perilaku seksual berisiko pada remaja
- 2) Kemungkinan terjadinya kehamilan
- 3) Kemungkinan IMS (Infeksi Menular Seksual)/ HIV
- 4) Kemungkinan adanya kekerasan seksual

h) *Safety* (Keselamatan)

Pada bagian '*Safety*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait dengan keselamatan.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Rasa aman remaja saat berada di keluarga
- 2) Rasa aman remaja saat berada di lingkungan (sekolah, masyarakat)
- 3) Rasa aman remaja saat berada di tempat umum.

i) *Suicide/ Depression* (Keinginan Bunuh Diri/ Depresi)

Pada bagian '*Suicide/Depression*' petugas memeriksa kemungkinan remaja memiliki masalah terkait risiko kecenderungan bunuh diri dan depresi.

Hal utama yang perlu digali antara lain:

- 1) Adanya keinginan/ kecenderungan remaja untuk menyakiti diri sendiri
- 2) Kecenderungan depresi, pola dan perilaku remaja apabila sedang merasa sedih/ cemas yang berlebihan.

(Kemenkes 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Siti Nur. 2020. "Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Puskesmas." *Journal of Public Health Research and Development (HIGEIA)* 4(4): 846–54.
- Azzopardi et al. 2019. "Progress in Adolescent Health and Wellbeing: Tacking 12 Headline Indicators for 195 Countries and Territoies 1990-2016." *Lancet* (393): 1101–18.
- BKKBN. 2011. "Kajian Profil Penduduk Remaja (10-24 Tahun) : Ada Apa Dengan Remaja." *Policy Brief Puslitbang kependudukan-BKKBN* 1.
- . 2012. *Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012*. Jakarta: BKKBN.
- Dachi, R. A. 2017. *Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diananda, Amita. 2018. "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya." *Journal ISTIGHNA* 1(1): 116–33.
- Kemenkes, RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014*. Jakarta: Kemenkes RI.
- . 2019. *Manajemen Terpadu Masalah Kesehatan Remaja Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. Jakarta: Kemenkes RI.
- . 2020. *Kemenkes, RI Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- . 2021. *PMK 21 Tahun 2021*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusmiran, E. 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sofia, Ari, and M A Adiyanti. 2013. "Hubungan Pola Asuh Otoritatif Orangtua Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Moral." *Jurnal Pendidikan Progresif* 4(2): 133–41.
- WHO. 2014. "World's Adolescents: A Second Chance in the Second Decade. Geneva, World Health Organization Departemen of Noncommunicable Disease Surveillance." *World Health Organization*: 3–6.
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/second-decade/en/.

BAB III

PSIKOLOGI REMAJA

Syahridayanti, S. ST., M. Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

PSIKOLOGI REMAJA

Syahridayanti, S. ST., M. Kes

A. Pendahuluan

Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Demikian pula dengan fase remaja, memiliki ciri-ciri yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula dari fase kanak-kanak, dewasa dan tua. Selain itu, setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan yang khas bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda dari fase satu ke fase yang lain. Hal ini tampak jelas ketika seseorang mengekspresikan emosi emosinya. Seperti bagaimana melepaskan stress dengan cara yang sesuai, mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata ketimbang tindakan negatif, mengatasi situasi sulit atau berbahaya dengan tenang, mengatasi situasi yang sedih dengan cara yang tepat, menangani situasi mengejutkan dengan kontrol menunjukkan kesukaan, kasih sayang, cinta terhadap orang lain dan lain sebagainya.

Pertumbuhan terjadi serentak dengan perkembangan fisik, sosial, kognitif, bahasa, dan kreatif. Namun, respon yang terjadi dari setiap fase perkembangan mengalami perubahan pada anak sejalan dengan berlangsungnya waktu karena kedewasaannya, lingkungan, reaksi orang lain disekitarnya, atau pembimbingan dari orang tua.

Remaja berada dalam status interim sebagai akibat daripada posisi yang diberikan oleh orang tua dan sebagian diperoleh dari usaha mereka sendiri yang selanjutnya memberikan prestise tertentu padanya. Status ini berhubungan dengan masa peralihan yang timbul sesudah pemasakan seksual (pubertas). Masa peralihan tersebut diperlukan untuk mempelajari remaja mampu memikul tanggung jawabnya nanti dalam masa dewasa. Oleh sebab itu suatu pendidikan yang emansipatoris akan membantu remaja untuk melepaskan status interimnya supaya ia dapat menjadi dewasa yang bertanggung jawab.

Psikologi remaja adalah bagian dari psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja. Disini remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang kelak menjadi penerus kehidupan untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman umat manusia dimuka bumi ini. Jika generasinya rusak maka secara otomatis bangsanya pun akan ikut rusak, sehingga demi mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mampu mencetak generasi yang berkualitas sesuai harapan bangsa dan Negara. Tetapi pada kenyataannya banyak generasi muda atau remaja juga menjadi gudang permasalahan. Perkembangan sosial dan kepribadian remaja akan berimplikasi

pada cara ia merespon pengetahuan atau pengalamannya. Dalam pendidikan, perkembangan sosial pada remaja akan mendorong ia untuk senantiasa mentaati peraturan sekolah, menjalin interaksi yang baik dengan teman sekolah, menghargai pendidik atau temannya yang sedang menjelaskan pelajaran.

B. Pembahasan

1. Psikologi perkembangan masa remaja

a. Perkembangan dan pertumbuhan fisik pada masa remaja

Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Pada mulanya, tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Baik anak laki-laki ataupun perempuan mengalami pertumbuhan yang cepat, yang disebut “growth spurt” (percepatan pertumbuhan), di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan.

b. Perkembangan emosi pada masa remaja

Sikap, perasaan atau emosi seseorang telah ada dan berkembang semenjak ia bergal dengan lingkungannya. Timbulnya sikap, perasaan atau emosi itu (positif atau negatif) merupakan produk pengamatan dari pengalaman individu secara unik dengan benda-benda fisik lingkungannya, dengan orang tua dan saudara-saudara, serta pergaulan sosial yang lebih luas. Sebagai suatu produk dari lingkungan (lingkungan internal dan eksternal) yang juga berkembang, maka sudah tentu sikap, perasaan/emosi itu juga berkembang.

Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri-hati, sedih, gembira, kasih sayang dan ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrolnya dengan baik.

c. Perkembangan sosial remaja

Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pematangan seksualitas, juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja. Sebelum masa remaja sudah ada saling hubungan yang lebih erat antara anak – anak yang sebaya. Sering juga timbul kelompok – kelompok anak, perkumpulan – perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama, misalnya untuk kemah, atau saling tukar pengalaman, merencanakan aktivitas bersama misalnya aktivitas terhadap suatu kelompok lain. Aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang – kadang kriminal seperti mencuri, penganiayaan, dll, dalam hal ini dapat dilakukan kelompok anak nakal.

Dalam perkembangan sosial remaja, dapat dilihat adanya dua macam gerak: satu yaitu memisahkan diri dari orang tua dan yang lain adalah menuju ke arah teman – teman sebaya. Dua macam arah gerak ini tidak merupakan dua hal yang berturutan meskipun yang satu dapat terkait pada yang lain. Hal itu menyebabkan bahwa gerak pertama tanpa adanya gerak yang kedua dapat menyebabkan rasa kesepian.

Anak – anak perempuan dan laki – laki betul – betul ada dalam situasi yang sama dalam status interim yang sama. Mereka sama – sama berusaha untuk mencapai kebebasan, mereka punya kecenderungan yang sama untuk menghayati kebebasan tadi sesuai dengan usia dan jenis seksnya. Adanya kesempatan yang berbeda antara laki – laki dan perempuan dalam masyarakat, bahwa perempuan juga ingin menduduki fungsi yang penting dalam masyarakat. Dorongan seperti ini yang memungkinkan adanya ingin berdiri sendiri.

2. Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Sekolah

Masalah kenakalan remaja di Indonesia semakin memprihatinkan dan menjelma menjadi masalah sosial yang kritis karena telah mengarah pada berbagai bentuk tindakan kriminalitas. Kesejahteraan psikologis pada remaja dapat menjadi pondasi bagi remaja dalam menghadapi masa kritis dan penuh gejolak pada periode remaja.

Dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kesejahteraan psikologis yang sedang. Sisanya, beberapa siswa yang lain termasuk dalam kategori tinggi dan rendah. Sedangkan dimensi yang paling berpengaruh adalah dimensi *Environmental Mastery* hal ini berarti remaja memiliki kompetensi dalam mengatur lingkungan, mengontrol situasi kompleks dan aktivitas eksternal, membuat kesempatan efektif di lingkungan, mampu memilih atau membuat konteks yang pas untuk kebutuhan dan nilai personal. Implikasi penelitian ini adalah dapat mengembangkan metode pembelajaran dengan membangun sistem kekeluargaan sehingga siswa merasa nyaman ketika menjalankan pendidikan di Sekolah.

3. Tingkah Laku Menyimpang Pada Remaja

Tingkah laku menyimpang adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa asing “*Juvenile Delinquency*” yang artinya adalah sebuah kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan yang bersifat asusila dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, agama, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tingkah laku ini merugikan diri sendiri dan orang lain.

Tingkah laku menyimpang ini merupakan salah satu permasalahan yang berkembang di kalangan remaja saat ini, hal ini ditandai dengan bermacam ragamnya tingkah laku menyimpang remaja yang tampak dalam kehidupan

sehari-hari. Baik dilakukan secara pribadi maupun berkempok. Di antaranya: tidak patuh pada nasihat orang tua, melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya, mencuri, menodong, berkhianat, mengkonsumsi narkoba, ugal-ugallan, dan lain sebagainya. Secara garis besar terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya tingkah laku menyimpang remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Teori Penyimpang :

- a. Teori differential Association
- b. Teori Labeling
- c. Teori Merton
- d. Teori fungsi Durkheim
- e. Teori Konflik

Perilaku seseorang dapat dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, yang melanggar aturan-aturan, nilai-nilai dan norma baik norma agama, norma hukum, dan norma adat.

Jenis dari perilaku menyimpang di tinjau dari :

- a. Berdasarkan sifat
 - b. Berdasarkan pelakunya
 - c. Berdasarkan identifikasinya
 - d. Berdasarkan efek
 - e. Berdasarkan bentuk atau jenis
4. Jejak Psikologis Remaja Dan Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Narapidana)

Tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berdasarkan tinjauan teoritis hasil temuan di lapangan dapat digambarkan sebagai proses mekanisme psikologis yang terdiri dari dua faktor utama, yaitu:

- a. Faktor internal

Faktor internal yang pertama adalah faktor kepribadian. Hubungan antara remaja dengan orang tua dan keluarga sangatlah penting dalam perkembangan kepribadian. Pada individu yang tidak mendapatkan kenyamanan dan kelekatan emosional dari orang tua atau figur pengasuh akan menyebabkan remaja tersebut tidak dapat mengembangkan rasa percaya sehingga dirinya akan mengembangkan rasa curiga. Kurangnya kontrol dan bimbingan orang tua juga mempengaruhi agresifitas pada remaja. Anggota keluarga yang terlibat tindak kriminal dapat mempengaruhi perilaku anggota keluarga lainnya untuk melakukan tindak kriminal yang sama melalui modelling.

Kemampuan berpikir yang rendah mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan dan berperilaku agresif, ditambah dengan konsumsi alkohol yang mempengaruhi syaraf otak dalam mengambil keputusan dan menyebabkan remaja cenderung melakukan tindak kekerasan.

Faktor internal ini berkoherensi dengan faktor eksternal, misalnya remaja yang tidak dapat mengembangkan kepercayaan akan mengembangkan kebingungan identitas sehingga remaja tersebut masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Pada lingkungan pergaulan yang tidak baik, remaja dapat meniru perilaku dari teman-temannya itu melalui belajar sosial. Seperti misalnya perilaku kekerasan, dan konsumsi alkohol.

Kebingungan identitas pada remaja juga menyebabkan remaja mencari penngakuan dari lingkungannya dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri demi mendapatkan barang yang lebih bagus dan melakukan tindak kekerasan agar dianggap superior oleh lingkungannya. Lingkungan pergaulan yang sering melakukan kekerasan dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan hal yang sama.

Dorongan seks yang tinggi dan tidak disalurkan dengan baik dapat menyebabkan remaja melakukan tindakan yang agresif untuk memuaskannya. Dalam kasus penelitian ini subjek membunuh lawan jenis agar dapat menyetubuhinya dengan mudah. Trait kepribadian tertentu juga berpengaruh pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Trait tersebut antara lain adalah narsisisme, oversensitif, dan impulsive.

b. Faktor eksternal

Lingkungan pergaulan remaja mempengaruhi pola perilaku remaja. Pada kasus dalam penelitian ini, subjek merupakan individu yang dekat dengan kelompok yang sering terlibat tindak kekerasan. Kurangnya tingkat pendidikan juga mendukung perilaku agresi pada remaja.

Tindak kejahatan juga dapat didahului oleh perbuatan korban, yaitu dalam kasus kali ini adalah korban sering mengenakan pakaian terbuka sehingga menimbulkan stimulus seksual bagi subjek. Selain itu korban juga sering terlihat menggunakan telepon genggam yang mahal sehingga menyebabkan keinginan subjek untuk mencuri telepon genggam milik korban.

5. Psikologi Remaja Berbasis Android (API MADRID)

Usia remaja merupakan masa yang sedang mengalami perkembangan fisiologis dan psikologis yang akan menimbulkan kecemasan. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan

emosionalitasnya terhambat sehingga akan mengakibatkan tingkah laku negatif misalnya agresif, lari dari kenyataan.

Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan dalam membantu remaja mengatasi permasalahan yang dialami adalah dengan memberikan bekal pengetahuan psikologi remaja. Untuk mempermudah akses informasi psikologi remaja, perlu adanya pengembangan aplikasi yang berfungsi sebagai media dalam belajar psikologi remaja.

Berdasarkan analisis situasi, penggunaan smartphone berbasis android kalangan remaja sudah menjadi kebutuhan pokok. Hampir setiap aktifitas yang mereka lakukan berhubungan dengan smartphone. Fakta ini yang menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan API MADRID, aplikasi psikologi remaja dengan memanfaatkan smartphone (berbasis android).

Hasil persentase kelayakan ujicoba aplikasi secara keseluruhan, didapatkan hasil sebesar 95.25% yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan skala likert. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kelayakan aplikasi API MADRID termasuk kategori "Sangat Layak".

6. Pengasuhan *Permissive* Orang Tua Dan Kenakalan Pada Remaja

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara pengasuhan *permissive* orang tua dan kenakalan pada remaja. Pola asuh permisif dilihat dari sikap orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang diinginkan. Sebagai contoh adalah orang tua mengizinkan anaknya pulang malam dan keluar pada malam untuk nongkrong. Konsekuensi dari diterapkannya pola asuh permisif adalah anak tidak akan tahu tingkah laku yang dilakukannya sesuai dengan aturan atau tidak, karena orang tua tidak pernah menyalahkan dan membenarkan tingkah laku tersebut.

Pola asuh permisif yang memberikan kebebasan, memanjakan anak, dan tidak adanya kontrol dari orang tua membuat anak cenderung melakukan perilaku negatif dan menyimpang. Sikap impulsif dan agresif, suka memberontak, kurang kendali diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, dan prestasinya rendah adalah sejumlah contoh perilaku negatif yang terbentuk. Selanjutnya sejumlah kenakalan mereka lakukan seperti melanggar aturan, berkelahi, membolos sekolah, bahkan sampai melakukan tindak kriminal.

Gaya pengasuhan orang tua adalah faktor terpenting dalam perkembangan psikososial anak-anak. Peran orang tua sangat diperlukan untuk mengasah kemampuan sosialisasi anak di lingkungan masyarakat serta menjaga rasa integritas pribadi. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu di rumah sehingga perilaku dan cara komunikasi orangtua dengan anak-anak juga berdampak pada mereka. Jika orang tua terlalu memanjakan dan

kurang adanya kontrol maka akan mendorong anak memiliki kepribadian yang buruk dalam kehidupan mereka. Semakin permisif pengasuhan yang dilakukan orangtua maka semakin besar kemungkinan terbentuknya perilaku kenakalan pada remaja.

C. Peran Bidan Dalam Mengatasi Masalah Psikologi Remaja

Dalam hal ini bidan melakukan sosialisasi kepada orang tua khususnya yang memiliki anak remaja untuk mengatasi masalah psikologinya yaitu dengan cara:

1. Komunikasi yang tepat
Komunikasi yang tepat dengan anak remaja menjadi hal utama yang harus dipahami oleh orang tua. Hindari komunikasi yang terkesan menggurui atau hingga menghakimi pendapat anak. Sebab komunikasi negatif adalah penyebab umum konflik antara orang tua dan remaja. Tetap hormati pendapat mereka dan berikan argumentasi yang tepat ketika pendapat anak mulai tidak masuk akal.
2. Memahami perasaan remaja
Mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja akan mengajak orang tua untuk lebih berempati pada anak. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan pendidikan agama, serta budi pekerti.
3. Mengendalikan diri
Orang tua perlu memahami waktu berkomunikasi yang tepat dengan anak . Dalam keadaan marah, hindari berkomunikasi dengan anak. Salah satu ciri umum remaja yaitu mereka senang memprovokasi orang tua sehingga orang tua bereaksi negatif. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh hilang kendali dan tetap tenang dalam menghadapi anak remaja.
4. Membuat batasan yang jelas
Orang tua dan anak perlu duduk bersama membuat aturan dan batasan-batasan jelas. Adapun batasan dan aturan tersebut harus masuk akal, memiliki alasan yang dapat diterima oleh anak dan orang tua. Membuat aturan bersama penting agar anak belajar bagaimana berkomitmen atas apa yang telah dibuat dan disetujuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cikal, Widyatmoko, dan Ika Febrian. Tt. *Remaja Dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Narapidana Di Lapas Kedung Pane Semarang*. Jejak Psikologis. Diakses 4 September 2022
- Diananda, Amita. 2018. *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*. Jurnal Psikologi. e: <http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id/index.php/istighna> Vol 1, No. 1, Januari 2018 P-ISSN 1979-2824. Diakses 4 Agustus 2022
- Fatmawaty, Riryn. tt. *Memahami Psikologi Remaja*. Jurnal Reforma Vol. VI No. 02. Unisla. Diakses 7 september 2022
- Marwoko , Gatot. Tt. *Psikologi Perkembangan Masa Remaja*. Diakses 4 Agustus 2022
- Mulyadi. Tt. *Tingkah Laku Menyimpang Remaja Dan Permasalahannya*. Jurnal Psikologi. Diakses 7 September 2022
- Prabowo, Adhyatman. 2016. *Kesejahteraan Psikologis Remaja Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Diakses 4 Agustus 2022
- Purwaningtyas, FD. 2020. *Pengasuhan Permissive Orang Tua dan Kenakalan pada Remaja*. Jurnal Penelitian Psikologi. <http://doi.org/10.29080/ipp.vllil.337>. Diakses 14 september 2022
- Putra, Mujono Sang & Yeni. 2021. *Pengembangan Aplikasi Psikologi Remaja Berbasis Android (API MADRID) Sebagai Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Pada Usia Remaja (Studi pada SMA N 2 Dompu)*. Jurnal Pendidikan, Vol.9, No.1, Januari 2021. ISSN: 2337-7607 e-ISSN: 2337-7593. Diakses 4 Agustus 2022

BAB IV

PERSONAL HYGIENE PADA REMAJA

Agustina, S.SiT., MKM



PERSONAL HYGIENE PADA REMAJA

Agustina, S.SiT., MKM

A. Pendahuluan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia [WHO] (2006) Resiko permasalahan terhadap kesehatan reproduksi wanita 33% lebih tinggi dari peningkatan untuk laki-laki yang hanya 12,3%. perawatan tubuh dalam merawat alat kelamin dimulai dengan pemilihan kain pada pakaian dalam, arah pembersihan vagina saat tinja bersih dan buang air besar, penggunaan pembalut dan perawatan organ kewanitaan lainnya, seperti menggunakan kondisioner atau mencuci bagian Alat kelamin dan lain-lain (Kusmiran, 2012).

Pada Remaja perempuan khususnya saat menstruasi, pembuluh darah di rahim sangat rentan terhadap infeksi. Remaja harus mengganti pembalut sesering mungkin saat berlumuran darah menstruasi. Hingga 90% wanita Indonesia, termasuk remaja, mungkin mengalami keputihan. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan). Proses dalam Kebersihan dan kesehatan seseorang yang tujuannya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain terhadap perkembangan penyakit, baik fisik maupun psikis (Zakiudin, 2016). Dari sini dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya, yaitu kebersihan dirinya sendiri.

Kebersihan diri perlu diperhatikan sehubungan dengan perawatan alat kelamin terutama dalam perawatan alat kelamin luar (Salmah, 2008). Menurut hasil penelitian Puspatinrum (2012), angkanya sama 66 persen dari mereka yang disurvei memiliki kebersihan diri yang kurang saat merawat organ tubuhnya terutama bagian genitalia eksterna dan 34% memiliki personal hygiene yang baik untuk pengobatan genitalia eksterna

Upaya peningkatan perilaku hidup sehat akan terus mendapat dukungan yang semakin meningkat dan dapat meminimalkan masuknya berbagai mikroorganisme yang ada dan pada akhirnya mencegah seseorang jatuh sakit. Peningkatan dan penguatan intervensi kesehatan yang kesemuanya digunakan secara efektif dan efisien merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari pola hidup yang buruk dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan kesehatan (Departemen Kesehatan RI, 2009).

1. Konsep Personal Hygiene

a. Definisi Personal Hygiene

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2020), *hygiene* atau kebersihan adalah tindakan kebersihan yang mengacu pada kondisi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Personal hygiene atau kebersihan tubuh berarti merawat diri sendiri, termasuk menjaga

kebersihan bagian tubuh seperti rambut, mata, hidung, mulut, gigi dan kulit (Toyin, 2020).

Kebutuhan akan kebersihan diri tidak menjadi masalah seiring bertambahnya usia, karena patogen dapat berkembang biak di mana saja. Oleh karena itu, personal hygiene harus diajarkan sejak dini, agar anak terbiasa di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain hingga dewasa (Muhlis, 2019).

Personal hygiene merupakan hal yang penting dan merupakan salah satu tindakan pencegahan primer yang spesifik, karena personal hygiene yang baik dapat meminimalisir masuknya mikroorganisme sistemik dan pada akhirnya mencegah seseorang dari sakit (Saryono, 2011).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Personal Hygiene

1) Citra tubuh (*body image*).

Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. *Personal hygiene* yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan citra tubuh individu. Citra tubuh ini dapat berubah misalnya oleh karena pembedahan atau penyakit fisik.

2) Praktik sosial

Praktik sosial memengaruhi kebersihan diri seseorang, salah satunya kebiasaan keluarga. Anak-anak prasekolah sedang mengalami perkembangan sosial dan mengikuti pola kebersihan yang sama dengan orang tua sebagai sosok figurnya (Puspita, 2017).

3) Status sosial ekonomi

Status ekonomi setiap individu memengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan seseorang karena dalam praktiknya *personal hygiene* memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sampo, dan alat lainnya, alat-alat tersebut tentu saja memerlukan uang untuk menyediakan alat tersebut.

4) Pengetahuan

Pengetahuan *personal hygiene* penting karena pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan. Meskipun demikian, jika hanya berpedoman pada pengetahuan saja tidak akan cukup dan seseorang harus memiliki motivasi dalam dirinya untuk merawat kebersihan diri. Berdasarkan temuan dalam penelitian menyatakan bahwa pengetahuan sangat berperan dan berpengaruh terhadap Pengetahuan yang baik terkait dengan perilaku perlu adanya pendidikan sebagai upaya untuk menambah pemahaman (Avrilinda, 2016).

5) Sosial Budaya

Latar belakang budaya atau kepercayaan kebudayaan memengaruhi *personal hygiene*. Seseorang dari latar budaya yang berbeda akan mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Misalnya, jika individu sedang sakit tertentu maka tidak boleh dimandikan.

6) Kebiasaan dan kondisi fisik

Setiap individu memiliki kebiasaan untuk ingin mandi dan pilihan kapan untuk mandi, bercukur dan melakukan perawatan lainnya. Kondisi fisik seseorang akan memengaruhi *personal hygiene*

c. Manfaat Personal Hygiene bagi Remaja

Manfaat dari *personal hygiene* bagi tiap individu menurut (Silalahi, 2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mempertahankan perawatan diri (*personal hygiene*) baik secara mandiri maupun dengan bantuan.
- 2) Melatih hidup bersih dan sehat dengan memperbaiki persepsi terhadap kebersihan dan kesehatan.
- 3) Mempertahankan penampilan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan.
- 4) Membuat rasa nyaman dan relaksasi untuk menghilangkan kelelahan.
- 5) Mencegah dari gangguan sirkulasi darah dan dapat mempertahankan integritas pada jaringan

d. *Personal hygiene* Remaja saat menstruasi

Personal hygiene saat menstruasi adalah tindakan memelihara kebersihan khususnya daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Tujuan *personal hygiene* menstruasi adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kesehatan diri, mencegah penyakit serta meningkatkan kepercayaan diri saat menstruasi (Setyaningsih, 2016).

Hasil penelitian Yanti (2014) menyatakan bahwa sebanyak 57,1% remaja putri memiliki pengetahuan baik tentang *personal hygiene* menstruasi. Penelitian Hassan (2012) menyatakan bahwa masih terdapat 52,3% remaja putri yang memiliki pengetahuan rendah tentang *personal hygiene* menstruasi. Penelitian Novianti, dkk. (2016) menyatakan bahwa 39,4% remaja putri memiliki pengetahuan kurang tentang *personal hygiene* menstruasi.

Personal hygiene yang harus diketahui remaja putri saat menstruasi menurut Sinaga (2017) sebagai berikut:

1) Perawatan kulit dan wajah

Wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi seorang remaja terutama remaja putri. Saat menstruasi kelenjar *sebaceous* meningkat sehingga merangsang produksi sebum (minyak). Oleh sebab itu, mencuci

muka dua sampai tiga kali sehari dapat membantu mencegah timbulnya jerawat.

2) Kebersihan rambut

Keramas saat menstruasi harus tetap dilakukan untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala, selain itu keramas juga dapat meningkatkan kepercayaan diri karena rambut menjadi bersih dan harum. Keramas harus dilakukan minimal dua hari sekali.

3) Kebersihan anggota badan

Mandi minimal dua kali sehari dengan sabun mandi karena saat menstruasi kelenjar keringat (*sebaceous*) akan meningkat sehingga produksi keringat meningkat.

4) Kebersihan tangan dan kuku

Kebersihan tangan dan kuku harus tetap dijaga terutama saat datangnya menstruasi pada remaja. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus dilakukan sebelum dan sesudah memegang genetalia. Tangan ataupun kuku yang kotor akan memudahkan kuman masuk khususnya saat membersihkan genetalia.

5) Kebersihan genetalia

Membersihkan genetalia dengan air bersih. Tidak perlu menggunakan cairan pembersih (antiseptik) saat membersihkan genetalia karena dapat membunuh bakteri baik yang ada di vagina. Bedak dan parfum juga tidak boleh digunakan di daerah genetalia. Cara membasuh organ reproduksi wanita yang benar adalah dari arah depan (vagina) ke belakang (anus), tidak terbalik karena bakteri yang ada di sekitar anus bisa terbawa ke dalam vagina dan berisiko menimbulkan infeksi. Setelah dibersihkan, vagina dikeringkan menggunakan handuk bersih atau tisu kering agar vagina tidak lembab.

6) Penggunaan pembalut

Fungsi utama pembalut adalah untuk menyerap dan menyesuaikan dengan darah haid. pembalut tidak boleh digunakan lebih dari empat jam. Pembalut harus diganti setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar. Pembalut harus diganti jika sudah penuh atau terdapat bekuan darah. Pasalnya, gumpalan darah yang ada di permukaan bantal bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri dan jamur.

Gunakan pembalut yang sudah jadi, bukan pembalut kain, karena dikhawatirkan pembalut tersebut tidak higienis akibat perawatan yang kurang baik, seperti. Vagina berbau tidak sedap. Pilihlah pembalut dengan daya serap tinggi, permukaannya yang kering dan tidak basah saat digunakan, pembalut terbuat dari bahan yang lembut dan lentur serta

tidak memiliki bau tertentu, pembalut tidak terbuat dari kertas daur ulang (bubur) dan pastikan pembalut belum tua kuno adalah (Hassan, 2012).

7) Kebersihan rambut genetalia

Kebersihan rambut genetalia saat menstruasi juga penting untuk dijaga. Hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut karena dapat menimbulkan lubang pada bekas bulu kemaluan tersebut dan menjadi jalan masuk bakteri, kuman, dan jamur. Perawatan rambut genetalia disarankan untuk dirapikan saja dengan memendekkan dengan gunting maksimal 40 hari. Rawat rambut genetalia secara teratur agar tidak menjadi sarang kutu dan jamur.

8) Kebersihan pakaian

Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting terutama pakaian dalam. Celana dalam yang baik adalah yang berbahan katun karena dapat menyerap keringat. Celana dalam yang digunakan tidak ketat, namun tetap dapat mengcover daerah pinggul agar dapat menopang pembalut dengan kuat. Celana dalam yang ketat akan membuat sirkulasi udara tidak lancar sehingga menimbulkan iritasi. Mengganti celana dalam minimal dua kali sehari dan segera ganti celana dalam apabila terkena noda darah.

e. Jenis-jenis Rempah Tradisional untuk *Personal Hygiene*

1) Daun Sirih

a) Pengertian Daun Sirih

Daun sirih tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan bisa dengan mudah didapatkan dimana saja, Keampuhan daun sirih sebagai obat penyembuh dari berbagai hasil penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa sirih mempunyai kandungan-kandungan yang sangat berkhasiat dan berjuta manfaat untuk kesehatan. Tradisi menyirih yang dapat menguatkan gigi karena masyarakat zaman dahulu sudah mengetahui khasiat daun sirih hijau yang dapat mengobati beberapa penyakit.

Daun sirih atau nama ilmiahnya *Piper Betle* Linn, merupakan tumbuhan obat yang banyak manfaatnya, sirih mengandung zat antiseptik hampir seluruh bagiannya, daun sirih dikenal sebagai tanaman obat yang sudah ada sejak 600 SM ini karena daun sirih mengandung zat antiseptic yang mampu membunuh kuman, daun sirih merupakan tanaman rambat yang daunnya berwarna hijau dan bentuk daunnya mirip jantung hati, diperkampungan tanaman daun sirih tumbuh begitu saja dipekarangan rumah (Nurmalina, 2012).

b) Manfaat Daun Sirih

Manfaat Daun Sirih Dalam buku kuno india yunani disebutkan daun ini memiliki sifat styptic (menahan pendarahan), vulnerary (menyembuhkan luka kulit), stomachic (obat saluran pencernaan), menguatkan gigi, sebagai obat sariawan dan membersihkan tenggorokan. Disebutkan bahwa daun sirih selain memiliki kemampuan antiseptik juga mempunyai kekuatan sebagai anti oksidasi dan fungisida. Daun sirih memiliki efek antibakteri terhadap streptococcus mutans, streptococcus sanguis, streptococcus viridans, actinomyces, dan staphylococcus aureus. Daun sirih merupakan tumbuhan obat tradisional disekitar kita yang dikenal dengan nama ilmiah Piper Beter L. Sejak sekitar tahun 600 SM, masyarakat tradisional asia dan india menggunakan daun sirih untuk berbagai keperluan mulai dari tata cara adat hingga pengobatan. Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal daun sirih sebagai bahan menginang dan keyakinan bahwa daun sirih dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil di dalam mulut, menghilangkan bau badan menghentikan pendarahan gusi dan sebagai obat kumur (Mutmainnah, 2014).

c) Obat Kumur

Obat kumur merupakan cairan atau larutan yang digunakan untuk membantu rongga mulut dan memberikan kesegaran serta membersihkan mulut dari plak dan organisme yang menyebabkan penyakit pada rongga mulut (Mervrayano, 2015). Obat kumur merupakan cairan yang berada dalam rongga mulut dalam beberapa waktu dengan menggunakan kekuatan mekanik oleh otot untuk menghilangkan patogen didalam mulut. Beberapa produk obat kumur terbaru mengklaim dan bahkan obat kumur sudah menjadi intens bahwa efektifitasnya dalam mengurangi penumpukan plak, halitosis, dan radang gusi (Manipal, 2016). Obat kumur herbal yang berasal dari tanaman, dapat berupa akar, batang, daun atau juga seluruh bagian tanaman. Obat herbal merupakan obat yang aman dan efektif yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki efek samping yang minimal. Obat kumur yang bermerek yang dijual dipasaran memiliki beberapa kekurangan karena menggunakan bahan kimia seperti pemanis buatan, pewarna buatan, pewangi.

d) Cara membuat obat kumur daun sirih:

- (1) Air yang digunakan untuk menyeduh daun sirih dipanaskan dengan suhu 100°C didinginkan pada suhu 70-80°C, Daun sirih hijau 4 lembar dicuci bersih dalam air mengalir dan diremas, dimasukan

kedalam gelas, diseduh dengan air panas sampai 200 ml, ditutup dan didinginkan kembali pada suhu 30°C, disaring, filtrat yang masih hangat digunakan untuk berkumur (Rosnaeni, 2013).

- (2) Air 200 ml direbus hingga mendidih pada suhu 100°C kemudian api dimatikan dan didiamkan hingga suhu air 70-80°C, daun sirih segar disiapkan sebanyak 4 lembar yang diambil dari urutan ke 4 ujung tunas tanaman sirih dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 5 cm kemudian diremas masukan kedalam gelas, air yang direbus dituang sebanyak 120 ml kedalam gelas yang berisi daun sirih, lalu diaduk dan tutup dengan penutup gelas dengan suhu air ditunggu hingga mendekati suhu ruangan 25-30°C agar dapat digunakan untuk dikumur tetapi air dalam gelas disaring terlebih dahulu (Rosnaeni, 2013).
- (3) Daun sirih seberat 6 gram dicuci sampai bersih kemudian dipotong - potong dan masukan kedalam air 120 ml dipanaskan pada suhu 90°C selama 15 menit, lalu di saring setelah itu masukan kedalam botol. (Irwanto 2009).
- (4) Daun sirih direbus pada suhu 120 C selama 15 menit daun sirih seberat 6 gram dimasukan kedalam 120 ml air direbus selama 15 menit setelah dingin kemudian disaring dan masukan kedalam botol agar terhindar dari kuman (Glaresia 2011).

2) Daun Sirih Merah

Penggunaan Tanaman Sirih Merah Kegunaan sirih merah di lingkungan masyarakat dalam menyembuhkan beberapa penyakit seperti, diabetes mellitus, asam urat, ambeien, penyakit ginjal, impotensi, dermatitis, gatal-gatal, luka bernanah yang sulit sembuh, karies gigi, batuk, radang pada mata, radang pada gusi dan telinga, hipertensi, keputihan kronis, sebagai obat kumur dan manfaat bagi kecantikan (lulur, masker, penuaan dini, penghalus kulit, dan lain-lain) (Juliantina, 2009).

a) Cara Penggunaan

Cara membersihkan organ wanita menggunakan daun sirih merah :

Bahan : Daun sirih merah yang siap panen minimal berumur 4 bulan, bisa dilihat dari lembar daun yang berukuran 5 – 10 cm dengan berat $\pm 6,5$ gram (8 lembar). Air 800 ml. Cara meramu : Mencuci daun kemudian iris-iris selebar 1 cm rebus dengan air 800 ml sampai mendidih. Cara menggunakan : Setelah dingin bisa digunakan untuk membasuh vagina dua kali sehari atau bisa dilakukan tiga hari dalam seminggu (Mardiana, 2013).

Sabun Resik-V Sabun resik-v merupakan sabun antiseptik pembersih daerah khusus kewanita. Penggunaanya yaitu dengan mencuci vagina, setelah itu dibilas dengan air bersih. Kandungan yang terdapat dalam sabun resik-v adalah ekstrak daun sirih hijau, triclosan, asam laktat, cocamidopropyl betain, TEA lauryl sulfat, polysorbat, sodium methylparaben, pengharum, dan air yang telah dimurnikan. Kandungan ekstrak daun sirih hijau di dalam resik-v inilah yang berfungsi sebagai antifungi (Moeljant, 2003). Kegunaan kandungan lain yang terdapat di dalam sabun resik-v dapat diuraikan sebagai berikut: a. Triclosan di dalam resik-v merupakan antibakteri dan antifungi yang sering digunakan dalam sabun antiseptik. b. Cocamidopropyl betaine berfungsi sebagai surfaktan sintesis yang membuat molekul sabun tersuspensi dengan mudah di dalam air. c. TEA lauryl sulfat adalah deterjen yang umum digunakan dalam bahan pembersih di berbagai produk perawatan. d. Polisorbat 20, dikenal pula sebagai Tween 20, berfungsi sebagai deterjen dan emulgator bagi Resik-V sabun sirih. e. Methylparaben memiliki fungsi antiseptik dan sering digunakan sebagai bahan di produk makanan, sabun pembersih, obat dan kosmetik (Moeljanto, 2003).

f. Teknik Pengolahan Tanaman Herbal untuk Personal Hygiene

Pengolahan secara sederhana dapat dilakukan melalui beberapa tahap antara lain:

1. Mengidentifikasi jenis tanaman herbal yang akan digunakan. Bermanfaat untuk mengetahui jenis tanaman herbal yang akan digunakan untuk mengobati penyakit tertentu. Berpedoman pada khasiat dan zat aktif yang terkandung pada jenis tanaman herbal tersebut.
2. Waktu pemetikan dan pengumpulan. Teknik dalam pemetikan dan pengumpulan tanaman herbal bermanfaat untuk menjaga kualitas dan kuantitas zat aktif yang terkandung di dalam tanaman herbal.
3. Penyortiran. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat herbal hendaknya disortir terlebih dahulu untuk membebaskan dari bahan asing atau kotoran. Penyortiran ini berfungsi untuk mendapatkan simplisia secara homogen yang meliputi jenis, ukuran, tingkat, kematangan dan lain-lain.
4. Pencucian. Pencucian simplisia dilakukan dengan air bersih yang mengalir atau yang dibersihkan dengan cara yang tepat sehingga diperoleh simplisia yang bersih dan terbebas dari mikroba patogen, kapang, khamir, serta pencemar lainnya. Jika menghendaki penggunaan simplisia segar maka setelah dicuci dapat segera diproses menjadi obat herbal sesuai yang dikehendaki.

- g. Intervensi remaja putri dalam melakukan personal hygiene saat menstruasi
Tindakan personal hygiene yang harus dilakukan remaja putri saat menstruasi menurut Sinaga (2017) sebagai berikut:
1. Cuci muka dua atau tiga kali sehari.
 2. Cuci atau kondisikan rambut Anda setidaknya dua hari sekali.
 3. Bersihkan shower dengan sabun mandi setidaknya dua kali sehari.
 4. Potong dan bersihkan kuku.
 5. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh kemaluan.
 6. Membersihkan kelamin dengan air bersih.
 7. Jangan menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan kemaluan.
 8. Jangan gunakan bedak atau parfum di area genital.
 9. Membasuh kemaluan dari bagian depan (vagina) sampai ke belakang (anus).
 10. Pembalut saat menstruasi tidak boleh digunakan lebih dari empat jam.
 11. Ganti pembalut setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar.
 12. Pembalut harus diganti bila sudah penuh atau terdapat bekuan darah.
 13. Pemendekan rambut kelamin.
 14. Kenakan celana dalam yang menyerap keringat dan tidak melar.
 15. Ganti celana dalam dua kali sehari dan segera ganti celana dalam jika ada darah di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, Glaresia Mellitania. (2011). Efektivitas Ekstrak Daun Sirih Sebagai Obat Kumur terhadap Penurunan Plak Indeks (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Kaliori Rembang). Universitas Negeri Semarang
- Avrilinda, Kristiatuti. 2016. *"Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Higiene Penjamah Makanan Di Kantin SMA Muhammadiyah 2 Surabaya."* e-journal Boga 5(2).
- Depkes RI. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. indonesia. Retrieved from [http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/general/UU_Nomor_36_Tahun2009_tentang_Kesehatan.pdf)
- Nurmalina, R dan Bandung Valley. 2012. *24 Herbal Legendaris untuk Kesehatan Anda*. Jakarta : Gramedia.
- Nurudeen, A. S. dan Toyin, A. 2020. Knowledge of Personal Hygiene among Undergraduates. *Journal of Health Education*. 5(2):66-71
- Kusmiran. 2012. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika.
- Moeljanto, D. R. & Mulyono, 2003, Khasiat dan Manfaat Daun Sirih, Bandung, Agromedia Pustaka
- Rosnaeni & Vinna K. Sugiaman. 2013. *Perbandingan Efek Berkumur Dengan Seduhan Sirih Hijau dan Teh Hitam Terhadap Indeks Plak Dengan Metode O'Leary*. 6(1): 1-10.
- Saryono & Widiati, A.T.2010, *Catatan Kuliah Kebutuhan Dasar Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Setianingsih, A. dan N. A. Putri. 2016. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Personal Hygiene Menstruasi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 5(1) : 15-23.
- Sinaga, E 2017, *Manajemen Kesehatan Menstruasi*, Iwwash, Jakarta
- Zakiudin A, Shaluhiah Z. Perilaku Kebersihan Diri (*Personal Hygiene*) Santri di Pondok Pesantren Wilayah Kabupaten Brebes Akan Terwujud Jika Didukung dengan Ketersediaan Sarana Prasarana. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*. 2016;11(2):64-83.

BAB V

ANEMIA PADA REMAJA PUTRI

Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.Si.T., M.Kes



ANEMIA PADA REMAJA PUTRI

Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.Si.T., M.Kes

A. Pendahuluan

Anemia merupakan keadaan penurunan jumlah masa eritrosit yang terlihat pada kadar hemoglobin, hematokrit dan eritrosit. Anemia memiliki gejala yaitu kehilangan selera makan, sulit focus, penurunan sistem kekebalan tubuh dan gangguan perilaku atau dikenal dengan 5 L (lemah, letih lesu, lelah dan lunglai), wajah pucat dan kunang-kunang (Naruddin, Syamsu & Permatasari, 2021). Hasil Survei Kesehatan Nasional Indonesia 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun, dan 15-24 tahun masing-masing adalah 28,1%, 26,4%, dan 18,4%. Terjadi peningkatan prevalensi dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2007, yaitu masing masing 27,7%, 9,4% dan 6,9% pada anak usia 1-4 tahun, 5-14 tahun dan 15-24 tahun (Naruddin, Syamsu & Permatasari, 2021). Berdasarkan data Riskesdas 2013 keadaan gizi pada kelompok usia 12-24 tahun di Indonesia masih memprihatinkan, prevalensi anemia pada WUS usia 15 tahun keatas sebesar 22,7% sedangkan pada ibu hamil sebesar 37,1%.

Pada masa pubertas remaja putri beresiko mengalami anemia gizi besi, hilangnya zat besi selama menstruasi dapat memperburuk kejadian anemia pada remaja putri. Keadaan ini juga diperburuk dari kurangnya asupan zat besi pada remaja putri yang juga dibutuhkan tubuh untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan (Kemenkes RI, 2018). Anemia pada remaja dapat memberikan dampak yaitu menurunnya Kesehatan reproduksi, gangguan perkembangan motoric dan mental, terhambatnya kecerdasan, menurunnya prestasi belajar (Jaelani, simanjuntak & Yuliantini, 2017)

Faktor penyebab anemia defisiensi besi dapat disebabkan karena kehilangan darah secara kronis, asupan zat besi dan penyerapan yang tidak adekuat serta peningkatan kebutuhan asupan zat besi untuk pembentukan sel darah merah yang berlangsung pada masa pubertas. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan anemia yaitu lama haid, kebiasaan sarapan pagi, status gizi, Pendidikan ibu, asupan zat besi dan protein tidak sesuai (Arisman, 2010).

B. Konsep Dasar Anemia

Anemia merupakan keadaan tubuh dimana hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah disbanding nilai normal. Anemia juga disebut dengan kurang darah atau kurangnya jumlah sel darah merah (eritrosit) (Taufiq, dkk (2020)). Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah/eritrosit yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya.

Kekurangan oksigen dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin dibentuk dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah/eritrosit. Anemia merupakan suatu gejala yang harus dicari penyebabnya dan penanggulangannya dilakukan sesuai dengan penyebabnya (Kemenkes RI, 2018).

C. Diagnosis Anemia

Penegakkan diagnosis anemia dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium kadar hemoglobin/Hb dalam darah dengan menggunakan metode *Cyanmethemoglobin* (WHO, 2001). Kadar Hb pada remaja putri berusia 12-15 tahun yaitu 12 g/dl, apabila remaja memiliki kadar Hb dibawah 12 g/dl maka remaja putri mengalami anemia (Taufiq,dkk, 2020).

Tabel 5.1
Klasifikasi Anemia menurut Kelompok Umur

Populasi	Non Anemia (g/dl)	Anemia		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak 6-59 bulan	11	10,0-10,9	7,0-9,9	< 7,0
Anak 5-11 Tahun	11,5	11,0-11,4	8,0-10,9	< 8,0
Anak 12-14 Tahun	12	11,0-11,9	8,0-10,9	<8,0
Perempuan tidak hamil (≥ 15 tahun)	12	11,0-11,9	8,0-10,9	<8,0
Ibu Hamil	11	10,0-10,9	7,0-9,9	< 7,0
Laki-laki(≥ 15 tahun)	13	11,0-12,9	8,0-10,9	< 8,0

Sumber : WHO, 2011

D. Penyebab Anemia

Anemia terjadi karena berbagai sebab, seperti defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12 dan protein. Secara langsung anemia terutama disebabkan karena produksi/kualitas sel darah merah yang kurang dan kehilangan darah baik secara akut atau menahun. Ada 3 penyebab anemia, yaitu (Kemenkes RI, 2018):

1. Defisiensi zat gizi

- Rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangann sumber zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah/eritrosit. Zat gizi lain yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin antara lain asam folat dan vitamin B12
- Pada penderita penyakit infeksi kronis seperti TBC, HIV/AIDS, dan keganasan seringkali disertai anemia, karena kekurangan asupan zat gizi atau akibat dari infeksi itu sendiri.

2. Perdarahan (*Loss of blood volume*)

- a. Perdarahan karena kecacingan dan trauma atau luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun.
- b. Perdarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan

3. Hemolitik

- a. Perdarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi (*hemosiderosis*) di organ tubuh, seperti hati dan limpa.
- b. Pada penderita Thalasemia, kelainan darah terjadi secara genetic yang menyebabkan anemia karena sel darah merah atau eritrosit cepat pecah, sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh

Pada remaja putri, penyebab tersering terjadinya anemia yaitu karena kekurangan zat besi (Iron/Fe). Fe merupakan zat gizi mikro penting bagi tubuh, Fe dibutuhkan pada proses pembentukan stuktur Hb yang berperan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Fe juga berperan dalam pembentukan kolagen (protein dalam tulang, tulang rawan dan jaringan penyambung) serta berhubungan pada reaksi enzimatik di dalam tubuh. Penyebab lain anemia adalah kekurangan asam folat atau vitamin B9 dan vitamin B12 (Taufiq, dkk, 2022)

E. Tanda dan Gejala Anemia

Menurut Kemenkes RI, 2018, gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lalai), disertai sakit kepala dan pusing (*"kepala muter"*), mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capai serta sulit konsentrasi. Secara klinis penderita anemia ditandai dengan "pucat" pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku dan telapak tangan.

Menurut Taufiq, dkk, 2022 Anemia dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium, namun terdapat beberapa tanda dan gejala yang dapat dijadikan petunjuk terjadinya anemia yaitu sebagai berikut:

1. Cepat merasa lelah: remaja putri mudah mengantuk dan sulit untuk berkonsentrasi
2. Lemah : malas beraktifitas dan seolah-olah merasa kekurangan energi
3. Sesak nafas: pada keadaan yang cukup berat, anemia juga sering kali disertai dengan sesak napas
4. Pucat: tanda pucat yang paling mudah ditemukan yaitu pada bagian konjungtiva dan telapak tangan
5. Pusing : rasa pusing dirasakan saat berubah posisi, perasaan ini paling banyak dirasakan saat posisi duduk kemudian berdiri
6. Sakit kepala
7. Jantung berdebar-debar

8. Tangan terasa dingin

F. Mengapa Remaja Putri rentan mengalami Anemia

Remaja putri (Rematri) lebih mudah menderita anemia, karena:

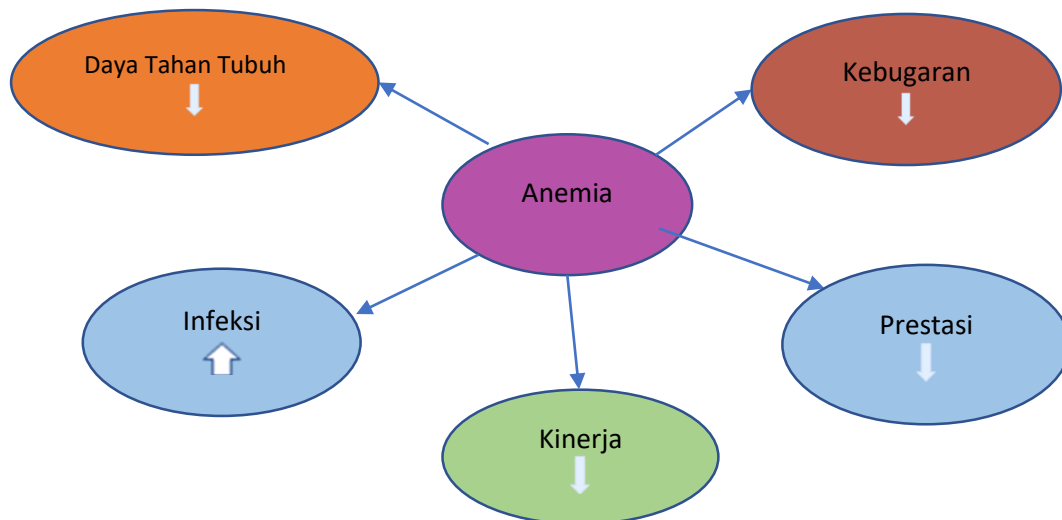
1. Rematri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya.
2. Rematri seringkali melakukan diet yang keliru yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, diantaranya mengurangi asupan protein hewani yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin darah.
3. Rematri dan WUS yang mengalami haid akan kehilangan darah setiap bulan sehingga membutuhkan zat besi dua kali lipat saat haid. Rematri dan WUS juga terkadang mengalami gangguan haid seperti haid yang lebih panjang dari biasanya atau darah haid yang keluar lebih banyak dari biasanya (Kemenkes RI, 2018)

Diantara semua kelompok umur, remaja adalah kelompok usia yang membutuhkan zat besi paling tinggi yaitu 26 mg/hari, hal ini dikarenakan pada masa ini remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Trend makanan dan minuman kekinian pada rematri saat ini tanpa sadar dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga rematri rentan mengalami anemia. Trend makanan dan minuman saat ini yang menghambat penyerapan zat besi yaitu the, kopi, coklat atau susu. Zat tannin di dalam teh, kopi, coklat serta kalsium dalam susu dapat mengikat zat besi dan mengganggu penyerapan zat besi (Taufiq,dkk, 2022).

G. Dampak Anemia

Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada rematri diantaranya:

1. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi
2. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak.
3. Menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja/kinerja



Gambar 5.1
Dampak Anemia

Sumber: *Effect of Iron and Zinc Supplementation on Iron, Zinc and Morbidity Status of Anemic Adolescent School Girls (10-12 years) in Tangerang District, 2004*

Dampak anemia pada rematri dan WUS akan terbawa hingga rematri menjadi ibu hamil anemia yang dapat mengakibatkan:

1. Meningkatkan risiko Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya *stunting* dan gangguan neurokognitif.
2. Perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya.
3. Bayi lahir dengan cadangan zat besi (Fe) yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini.
4. Meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi.

H. Cara Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Rematri dan WUS

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dilakukan dengan memberikan asupan zat besi yang cukup ke dalam tubuh untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin. Upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi
Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang, yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi (besi *heme*) dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi (besi *non-heme*), walaupun penyerapannya lebih rendah dibanding dengan hewani. Makanan yang kaya sumber zat besi dari hewani contohnya hati, ikan, daging dan unggas, sedangkan dari nabati yaitu sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati

perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu. Penyerapan zat besi dapat dihambat oleh zat lain, seperti tanin, fosfor, serat, kalsium, dan fitat.

2. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi

Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi kedalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Penambahan zat gizi dilakukan pada industri pangan, untuk itu disarankan membaca label kemasan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut sudah difortifikasi dengan zat besi. Makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia antara lain tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa *snack*. Zat besi dan vitamin mineral lain juga dapat ditambahkan dalam makanan yang disajikan di rumah tangga dengan bubuk tabur gizi atau dikenal juga dengan *Multiple Micronutrient Powder*.

3. Perhatikan asupan Protein

Protein merupakan bahan baku penting untuk pembentukan sel darah merah, namun tidak semua protein mengandung zat besi yang sama. Berikut makanan yang mengandung zat besi:

Tabel 5.2 Makanan Mengandung Zat Besi

Hati	Daging	Sayuran
• Hati Ayam (8,5 mg/100 g) • Hati Sapi 6,8 mg/100 g)	• Daging Sapi (1,8 mg/100 g) • Daging Kambing (1,7 mg/100 g) • Daging ayam (1,4 mg/100 g) • Daging bebek (2,7 mg/100 g)	• Sumber zat besi dari sayuran hijau sedikit dan tingkat penyerapan oleh tubuh sangat rendah • Bayam (3,1 mg/100 g)

Untuk mencukupi kebutuhan harian zat besi, remaja putri sebaiknya mengonsumsi minimal 3 sumber protein hewani dan 1 di antaranya harus berupa daging seperti daging sapi, hati sapi atau ayam.

4. Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung asam folat (B9) dan vitamin B12

Anemia juga dapat ditimbulkan oleh kekurangan asam folat dan kobalamin, sehingga sangat dianjurkan untuk mengonsumsi bahan pangan bersumber kedua vitamin tersebut seperti daging, ayam, ikan, pisang, jeruk dan wortel.

5. Hindari mengonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi

Hindari mengonsumsi the, kopi, coklat dan susu secara bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan.

6. Mengonsumsi makanan yang membantu penyerapan zat besi

Mendampingi menu utama dengan makanan kaya vitamin c untuk meningkatkan penyerapan zat besi

7. Suplementasi zat besi

Pada keadaan dimana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapat dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) pada rematri dan WUS merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi asupan zat besi. Pemberian TTD dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh.

I. Cara mengkonsumsi TTD

Mengonsumsi zat besi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di ulu hati, mual, muntah atau sembelit, hal ini tidak berbahaya dan dapat dicegah dengan memperhatikan cara penyimpanan dan konsumsi TTD yang benar

1. Cara penyimpanan TTD

- a. Disimpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung
- b. Teempatkan pada tempat yang aman serta jauh dari jangkauan anak-anak

2. Cara mengkonsumsi TTD

- a. 1 tablet perminggu dan 1 tablet setiap hari di masa menstruasi
- b. Diminum di malam hari menjelang tidur untuk mencegah timbulnya rasa mual. TTD dapat diminum selain malam hari dan tidak mengurangi efektivitas dari TTD tersebut.
- c. TTD diminum dengan air putih atau minuman yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi.
- d. Mengonsumsi TTD dapat menimbulkan efek samping nyeri atau perih pada ulu hati, mual dan muntah, tinja berwarna hitam. Untuk menghindari gejala tersebut TTD dianjurkan diminum setelah makan (perut tidak kosong) atau malam sebelum tidur
- e. Hindari mengonsumsi TTD dengan teh, kopi, susu atau coklat
- f. Mengonsumsi gizi seimbang dengan memperhatikan asupan protein hewani untuk mencukupi gizi harian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman MB. 2010. Gizi Daur Kehidupan. Jakarta: Buku Kedokteran Cetakan XII. Penerbit: EGC
- Indriastuti, Yustina A. *Thesis report: Effect of Iron and Zinc Supplementation on Iron, Zinc and Morbidity Status of Anemic Adolescent School Girls (10-12 years) in Tangerang District*, 2004
- Jaelani, Simanjuntak & Yuliastini. 2017. Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan*, VII (3), Hal 358-368
- Kementrian Republik Indonesia. 2018. Pedoman dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS). Jakarta: Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat.
- Naruddin, Syamsu & Permatasari. 2021. Angka Kejadian Anemia Pada Remaja di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1 (4), 357-364
- Taufiq, dkk (2020). *Aku Sehat Tanpa Anemia*. Jakarta: Wonderland Publisher
- WHO. 2011. *Haemoglobin Concentrations for the Diagnosis of Anaemia and Assessment of Severity*. Geneva: World Health Organization

BAB VI

SENAM DISMENOREA

Lusi Afriyani, S.S.T.,M.Tr.Keb.



SENAM DISMENOREA

Lusi Afriyani, S.S.T., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan

Menstruasi merupakan keluarnya darah dari uterus melalui vagina yang terjadi secara rutin setiap bulannya dimana hal tersebut akan dialami sebagian besar wanita usia reproduktif dengan siklus serta waktu yang berbeda dari setiap orang (Lilis Fatmawati, 2018). Wanita usia reproduktif memiliki pengalaman menstruasi yang berbeda – beda, sebagian wanita mendapatkan menstruasi tanpa keluhan, namun tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan menstruasi dengan disertai keluhan yang mengakibatkan rasa ketidaknyamanan berupa rasa sakit dibagian perut serta bagian tubuh lainnya yang sering disebut dengan istilah dismenorea (Merry, 2020).

Dismenorea merupakan rasa nyeri yang dialami sebelum atau selama menstruasi berlangsung. Dismenore biasanya ditandai dengan adanya rasa nyeri bagian perut dan berlangsung sekitar 8 – 72 jam bahkan bisa 1 – 2 hari saat menstruasi. Pada umumnya rasa sakit tersebut disertai dengan gejala seperti pusing, muntah, kelelahan, nyeri bagian perut bawah sampai kepinggang dan sulit untuk tidur. Dismenorea juga dapat berdampak negatif pada kualitas hidup wanita dan mengganggu aktivitas sehari – hari (Nurmala Djimbula, 2022).

Dismenorea juga dapat mengakibatkan nyeri spasmodik dan nyeri kongestif. Nyeri spasmodik nyeri yang terasa di bagian bawah perut dan berawal sebelum masa haid atau segera setelah masa haid mulai, yang mengakibatkan merasa sangat mual, muntah bahkan juga ada diantaranya mengalami pingsan (Ayu Astuti et al., 2021). Nyeri kongestif dapat mengakibatkan nyeri pada kedua payudara, perut kembung, sakit kepala, sakit punggung, pegal pada paha, mudah tersinggung, merasa lelah, mudah ceroboh atau emosian, terganggu tidur dan muncul memar di paha dan lengan atas (Hasrawati, 2022).

Menurut data World Health Organization (WHO) ada sekitar 50 % wanita didunia mengalami dismenorea, angka dismenorea sekitar 72 % di Swedia, 85,7 % di Arab Saudi, 85,4 % di Ethiopia, 64,0 % di Meksiko, 89,10 % di Iran, dan Amerika Serikat diperkirakan hampir 90 % wanita mengalami dismenorea. Di Indonesia sendiri jumlah dismenorea sebanyak 64,25 % yang dimana 54,89 % mengalami **dismenorea primer** dan 9,36 % dismenorea sekunder (Roihatul Zahroh, 2020).

Dismenorea primer adalah kondisi yang berhubungan dengan siklus pembuahan, dimana dismenore primer terjadi akibat pelepasan hormone prostaglandin selama menstruasi. Dismenorea primer biasanya muncul diumur 6 – 12 bulan setelah menstruasi pertama kali ketika ovulasi dimulai. Faktor penyebab dismenorea primer adalah ketidak seimbangan hormonal dan faktor stres yang mengakibatkan gangguan pada kemampuan berpikir, emosi, perilaku serta komunikasi (Nur Partiwi, 2021). **Dismenorea sekunder** adalah nyeri menstruasi yang

terjadi umumnya setelah usia 25 tahun. Dismenoreia sekunder berhubungan dengan abnormalitas panggul seperti adenomiosis, endometriosis, penyakit radang panggul, polip endometrium, mioma, atau penggunaan alat kontrasepsi dalam kandungan (Domas Nurchandra Pramudianti, 2022).

Nyeri dismenore yang dialami para wanita saat menstruasi seringkali mengganggu aktifitas sehari – hari misalnya tidak bisa pergi sekolah, bekerja dan lain sebagainya namun apabila masalah seperti ini tidak segera diatasi maka akan berakibat fatal, maka dari itu perlu adanya penanganan yang efektif dan tepat untuk meminimalkan nyeri yang dirasakan oleh sebagian wanita usia produktif (Ayu Idaningsih dan Fitri Oktarini, 2020). Agar tidak mengganggu kenyamanannya saat beraktivitas upaya mengatasi dismenoreia dapat dilakukan dengan dua jenis terapi yaitu farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi yaitu pemberian obat analgetik, terapi hormonal, obat nonsteroid prostaglandin, dan dilatasi kanalis servikalis. Sedangkan non farmakologi untuk mengurangi nyeri dismenore yaitu kompres hangat, olahraga atau senam, dan relaksasi (Sasi Sri Parhanah, 2021).

Senam dismenoreia merupakan aktivitas fisik yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dismenoreia, saat melakukan senam tubuh akan menghasilkan endorfin, hormon endorfin yang semakin tinggi akan menurunkan atau meringankan nyeri yang dirasakan wanita sehingga akan menjadi lebih nyaman, gembira, dan melancarkan pengiriman oksigen ke otot (Nurmala Muthiah Azhari, 2021). **Senam dismenore** tidak membutuhkan biaya yang mahal, mudah dilakukan dan tentunya tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh (Yeti Trisnawati & Putri, 2021). **Senam dismenoreia** juga merupakan salah satu bentuk relaksasi yang sangat di anjurkan mengingat senam ini dapat membantu melancarkan aliran darah pada otot sekitar rahim sehingga rasa nyeri dapat berkurang atau diatasi (Nuraisyah Hutagalung, 2022). Gerakannya terdiri dari gerakan pelepasan dan peregangan otot (Listyana Natalia R, 2022).

B. Pengertian remaja

Menurut World Health Organization (WHO) remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak – kanak ke masa dewasa, usia remaja adalah 10 – 24 tahun (Baiq Nursyahrani Pajriatussani, 2022). Remaja merupakan sebagai titik awal proses reproduksi, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Masa remaja atau juga disebut masa pubertas merupakan masa penghubung antara masa anak – anak dan dewasa. Dalam siklus kehidupan pubertas merupakan tahapan yang penting dalam perkembangan seksualitasnya (Laelika Ramadanti, 2022).

Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seseorang. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan

social. Perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh remaja adalah pertumbuhan tubuh (badan semakin panjang dan tinggi). Selanjutnya mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan menstruasi pada wanita) dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh, diantara tanda-tanda sekunder tersebut salah satunya menstruasi (Clara Wulanda, 2020).

Remaja merupakan suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seseorang. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan social (Chandrayani & Irne Wida Desiyanti, 2022). Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, ditandai adanya percepatan perkembangan fisik, emosi, mental dan social. Perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh remaja yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa remaja yaitu pertumbuhan tubuh seperti badan semakin tinggi dan panjang. Diikuti dengan mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan menstruasi pada wanita) menstruasi ini sebagai tanda seksual sekunder pada remaja dan ada beberapa remaja yang mengalami gangguan pada saat menstruasi yaitu mengalami nyeri pada saat menstruasi dismenore (DWI APRIANI, 2021).

Remaja putri yang mengalami nyeri haid (dismenore) pada saat menstruasi akan merasa terbatas dalam melakukan aktivitas khususnya aktivitas belajar di sekolah. Aktivitas belajar adalah keterlibatan seseorang dalam bentuk sikap, pikiran dan perhatian dalam kegiatan belajar sebagai penunjang keberhasilan proses belajar mengajar sehingga diperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Remaja putri yang sedang mengalami nyeri haid (dismenore) sekaligus mengikuti kegiatan pembelajaran, dapat menyebabkan aktivitas pembelajaran menjadi terganggu, tidak bersemangat, konsentrasi menjadi menurun bahkan sulit berkonsentrasi sehingga materi yang disampaikan selama pembelajaran tidak dapat diterima dengan baik bahkan sampai ada yang tidak masuk sekolah (Rya Anastasya Siregar, 2021).

Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ – organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Pubertas merupakan titik pencapaian dari kematangan seksual pada anak perempuan yaitu dengan terjadinya menarche, adapun perubahan yang terjadi pada perempuan seperti payudara dan pinggul membesar, tubuh bertambah tinggi, tumbuh rambut ketiak dan kemaluan, serta haid (Clara Wulanda, 2020). Ciri pubertas pada remaja laki – laki, hormon testosteron akan mengakibatkan tumbuhnya rambut – rambut halus di sekitar ketiak, kemaluan, tumbuh janggut dan kumis terjadi perubahan suara, tumbuh jerawat dan mulai diproduksi sperma yang pada waktu waktu tertentu keluar sebagai mimpi basah (IMA PURNAMA SARI, 2019).

Menstruasi dimulai saat pubertas dan kemampuan seorang wanita untuk mengandung anak atau masa reproduksi. Ketika menstruasi tiba, ada kalanya terdapat kelainan atau gangguan yang ada hubungan dengan menstruasi diantaranya premenstrual tension (ketegangan sebelum haid), mastodinia, mittelschmerz (rasa nyeri saat ovulasi) dan dismenore (rasa nyeri saat menstruasi). Menstruasi atau haid atau datang bulan merupakan perubahan fisiologis dalam wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, yang dimulai dari masa menarche sampai menopause. Menstruasi ada kalanya disertai kelainan atau gangguan diantaranya premenstual tension (ketegangan sebelum haid), mastodinia (rasa sakit dipayudara sebelum menstruasi), mittelschmerz (rasa nyeri saat ovulasi), dan dismenore (Wella Anggraini, 2022).

C. Konsep Dismenorea

1. Pengertian

Dismenore berasal dari kata “dys” dan “menorea”. Dys atau dis adalah awalan yang berarti buruk, salah dan tidak baik. Menorea atau mens adalah pelepasan lapisan uterus yang berlangsung setiap bulan berupa darah atau jaringan dan sering disebut dengan haid atau menstruasi. Dismenore adalah nyeri diperut bagian bawah, menyebar ke daerah pinggang dan paha. Nyeri ini timbul tidak lama sebelum atau bersamaan dengan hari pertama haid dan berlangsung untuk beberapa jam, walaupun beberapa kasus dapat berlangsung beberapa hari. Nyeri dapat bersifat sementara dan terus menerus. Dismenore timbul akibat kontraksi disritmik lapisan myometrium yang menampilkan satu lebih gejala mulai dari nyeri ringan hingga berat pada perut bagian bawah, daerah pinggang dan sisi medial paha (IMA PURNAMA SARI, 2019).

Dismenore merupakan rasa nyeri pada saat menstruasi yang terasa diperut bagian bawah menyebar ke bagian pinggang dan paha. Dismenore terjadi karena adanya kontraksi distritmik lapisan myometrium yang menampilkan satu atau gejala mulai dari nyeri ringan hingga berat. Nyeri timbul tidak lama sebelum atau bersama-sama dengan permulaan haid dan berlangsung beberapa waktu (Ida Nurjanah, 2019). Dismenore atau nyeri haid merupakan suatu rasa tidak enak di perut bawah sebelum dan selama menstruasi dan sering kali disertai rasa mual. Dismenorea adalah nyeri haid yang sedemikian hebatnya sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau cara hidupnya sehari-hari, untuk beberapa jam atau beberapa hari (Ernawati Sinaga, 2017).

Dismenore adalah nyeri saat haid, biasanya dengan rasa kram dan terpusat di abdomen. Keluhan nyeri haid dapat terjadi bervariasi mulai dari yang ringan sampai berat. Keparahan *dismenore* berhubungan langsung dengan lama

dan jumlah darah haid. Seperti diketahui haid hampir selalu diikuti dengan rasa mulas atau nyeri. Namun, yang dimaksud dengan *dismenore* pada topik ini adalah nyeri haid berat sampai menyebabkan perempuan tersebut datang berobat ke dokter atau mengobati dirinya sendiri dengan obat anti nyeri. *Dismenore* adalah nyeri pada daerah panggul akibat menstruasi dan produksi zat prostaglandin. Seringkali dimulai segera setelah mengalami menstruasi pertama (*menarche*). Nyeri berkurang setelah menstruasi, namun pada beberapa wanita nyeri bisa terus dialami selama periode menstruasi. Penyebab nyeri berasal dari otot rahim. Seperti semua otot lainnya, otot rahim dapat berkontraksi dan relaksasi (Mahmudah, 2020).

Dismenore merupakan gejala yang normal. Meskipun normal, akan tetapi pada beberapa kasus bisa terjadi dismenore berat bila tidak ditangani. Dampak yang terjadi jika dismenore tidak ditangani dapat mengganggu aktifitas hidup sehari-hari, menstruasi yang bergerak mundur, kemandulan, kehamilan tidak terdeteksi atau kehamilan ectopik pecah, kista, dan infeksi. Penyebab dismenore bisa bermacam-macam, bisa karena suatu proses penyakit (misalnya radang panggul), endometriosis, tumor atau kelainan letak uterus, dan stress atau kecemasan yang berlebihan. Oleh karena itu pada usia remaja dismenore harus ditangani agar tidak terjadi dampak seperti yang sudah dijelaskan (Sitohang & Nasution, 2021).

2. Penyebab Dismenorea

Penyebab pasti dismenorea hingga kini belum diketahui secara pasti (*idiopatik*), namun beberapa faktor ditengarai sebagai pemicu terjadinya nyeri menstruasi, diantaranya faktor psikis (seperti mudah mengalami emosi yang tidak stabil). Faktor endokrin (Timbulnya nyeri menstruasi diduga karena kontraksi rahim (uterus) yang berlebihan). Faktor prostaglandin (Nyeri menstruasi timbul karena peningkatan produksi prostaglandin oleh dinding rahim saat menstruasi). Anggapan ini mendasari pengobatan dengan antiprostaglandin untuk meredakan nyeri menstruasi. Penyebab lain dari *dismenore* antara lain memiliki penyakit radang panggul, pemasangan IUD dan bekas luka karena melakukan operasi pada organ reproduksi (Ernawati Sinaga, 2017).

3. Jenis – Jenis Dismenorea

a. Dismenorea Primer

Dismenorea primer adalah nyeri tanpa ditemukan keadaan patologi pada panggul yang berhubungan dengan siklus ovulasi dan disebabkan oleh kontraksi miometrium sehingga terjadi iskemia akibat adanya prostaglandin

yang diproduksi oleh endometrium fase sekresi. Molekul yang berperan pada *dismenore* adalah hormone prostaglandin yang selalu menstimulasi kontraksi uterus, dan menghambat kontraksi uterus. Terdapat peningkatan kadar hormone prostaglandin di endometrium saat perubahan dari fase proliferasi ke fase sekresi, peningkatan biasanya saat terjadi haid 48 jam pertama. Hal ini sejalan dengan awal muncul dan besarnya intensitas keluhan nyeri haid seperti mual, muntah, nyeri kepala, atau diare yang sering menyertai *dismenore* karena masuknya prostaglandin ke sirkulasi sistemik (Sitohang & Nasution, 2021).

b. Dismenorea Sekunder

Dismenore sekunder dapat terjadi kapan saja setelah haid pertama, tetapi yang paling sering muncul di usia 20-30 tahunan, setelah bertahun-tahun normal dengan siklus tanpa nyeri. *Dismenore* sekunder adalah nyeri haid yang berhubungan dengan berbagai keadaan patologis di organ seperti *endometriosis* (kejadian di mana jaringan endometrium berada di luar rahim, dapat di tandai dengan nyeri haid), *adenomyosis*, *mioma uteri*, *stenosis serviks*, penyakit radang panggul, perlekatan panggul, atau *irritable bowel syndrome* (Domas Nurchandra Pramudianti, 2022).

4. Penyebab Dismenorea

a. Faktor endokrin

Rendahnya kadar progesteron pada akhir fase *corpus luteum*. Hormon progesteron menghambat atau mencegah kontraktilitas uterus sedangkan hormon estrogen merangsang kontraktilitas uterus). Di sisi lain, endometrium dalam fase sekresi memproduksi hormone prostaglandin sehingga menyebabkan kontraksi otot-otot polos.

b. Kelainan organik

Seperti, retrofleksia uterus (kelainan letak arah anatomis rahim), hipoplasia uterus (perkembangan rahim yang tak lengkap), obstruksi kanalis servikalis (sumbatan saluran jalan lahir), mioma submukosa bertangkai (tumor jinak yang terdiri dari jaringan otot).

c. Faktor kejiwaan dan gangguan psikis

Seperti rasa bersalah, ketakutan, seksual, takut hamil, hilangnya tempat berteduh, konflik dengan masalah lawan jenis, dan imaturitas (belum mencapai kematangan).

d. Faktor konstitusi

Penyakit anemia dan penyakit menahun juga dapat mempengaruhi timbulnya *dismenore*.

e. Faktor alergi

Penyebab alergi adalah toksin haid. Menurut riset, ada hubungan antara dismenore dengan urtikaria (biduran), migran, dan asma.

1) Penyebab dismenore sekunder

- a) Intrauterine contraceptive devices (alat kontrasepsi dalam rahim)
Adanya benda asing dapat meningkatkan aktivitas uterus yang dapat menimbulkan rasa nyeri di abdomen.
- b) Penyakit radang panggul kronis. Peradangan atau infeksi pada organ-organ yang terdapat pada panggul wanita. Organ panggul termasuk uterus (rahim), tuba falopi (saluran telur), indung telur, dan leher rahim. Gejalanya seperti nyeri perut bagian bawah, nyeri dan atau perdarahan ketika melakukan hubungan.
- c) Uterine leiomyoma (tumor jinak otot rahim). Pertumbuhan yang terdiri dari sel-sel otot polos dan jaringan ikat fibrosa biasanya ditemukan dalam dinding rahim. Beberapa tumbuh
- d) dibawah lapisan rahim dan tumbuh diantara otot-otot rahim. Gejalanya seperti nyeri di perut atau di pinggul, nyeri haid, perdarahan haid yang tidak normal (lebih banyak atau lebih lama).
(Ernawati Sinaga, 2017).

5. Faktor Risiko Disminorea

a. Faktor risiko disminorea primer

- 1) Usia saat menstruasi pertama kurang dari 12 tahun atau usia awal. Menarche pada usia lebih awal menyebabkan alat-alat reproduksi belum berfungsi secara optimal dan belum siap mengalami perubahan – perubahan sehingga timbul nyeri ketika menstruasi.
- 2) Belum pernah hamil dan melahirkan. Perempuan yang hamil biasanya terjadi alergi yang berhubungan dengan saraf yang menyebabkan adrenalin mengalami penurunan, serta menyebabkan leher rahim melebar sehingga sensasi nyeri haid berkurang bahkan hilang.
- 3) Haid memanjang atau dalam waktu lama. Lama menstruasi lebih dari normal (7 hari), menstruasi menimbulkan adanya kontraksi uterus, terjadi lebih lama mengakibatkan uterus lebih sering berkontraksi, dan semakin banyak prostaglandin yang berlebihan menimbulkan rasa nyeri, sedangkan kontraksi uterus yang terus menerus menyebabkan suplai darah ke uterus terhenti dan terjadi dismenorea.
- 4) Merokok. Karena didalam asap rokok terkandung racun-racun yang berbahaya bagi sistem reproduksi. Racun-racun yang mengendap dalam tubuh dan tidak dapat keluar dalam tubuh akan bersifat toksik pada

organ tubuh manusia salah satunya dapat mempengaruhi keseimbangan hormon. Sedangkan pada wanita dalam proses ovulasi dan menstruasi sangat bergantung pada keseimbangan hormon terutama hormon estrogen dan hormon progesteron. Dengan terganggunya keseimbangan kedua hormon tersebut maka menghambat terjadinya ovulasi (pematangan sel telur) dan dengan terhambatnya pematangan sel telur ini maka akan menghambat pula terjadinya pembuahan jika ada sperma yang datang untuk membuahnya. Serta menghambat terjadinya peluruhan endometrium atau yang sering di sebut menstruasi.

- 5) Tidak pernah berolah raga. Kejadian dismenore akan meningkat dengan kurangnya aktifitas selama menstruasi dan kurangnya olah raga. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi darah dan oksigen menurun. Dampak pada uterus adalah aliran darah dan sirkulasi oksigen pun berkurang dan menyebabkan nyeri.

b. Faktor risiko disminorea sekunder

- 1) Endometriasis. Radang yang terkait dengan hormon estradiol atau estrogen berupa pertumbuhan jaringan endometrium yang disertai perambatan pembuluh darah, hingga menonjol keluar dari rahim.
- 2) Adenomyosis. Suatu kondisi dimana jaringan endometrium, tumbuh ke dalam otot rahim. Kondisi tersebut paling mungkin terjadi pada akhir masa subur dan setelah memiliki anak.
- 3) IUD. Sebuah alat kontrasepsi berupa kumparan kecil panjang 3 cm dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Seorang perempuan yang memasang IUD namun hamil harus melakukan USG karena kemungkina terjadinya kehamilan ektopik lebih tinggi.
- 4) Pelvic inflammatory disease (penyakit radang panggul). Peradangan atau infeksi pada organ-organ yang terdapat pada panggul wanita. Organ panggul termasuk uterus (rahim), tuba falopi (saluran telur), indung telur, dan leher rahim.
- 5) Endometrial carcinoma (kanker endometrium). Jaringan atau selaput lendir rahim yang tumbuh di luar Rahim. Padahal, seharusnya jaringan endometrium melapisi dinding rahim.
- 6) Ovarian cysts (kista ovarium). Tumor jinak berupa kantong abnormal berisi cairan atau setengah cair yang tumbuh dalam indung telur (ovarium).

(Mahmudah, 2020).

6. Tanda Dan Gejala Dismenorea

- a. Nyeri pada perut yang menjalar sampai ke punggung bagian bawah dan tungkai
- b. Nyeri yang dirasakan seperti kram bisa hilang timbul atau bisa juga nyeri tumpul yang ada secara terus – menerus
- c. Nyeri mulai timbul sesaat sebelum dan atau selama menstruasi serta mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang
- d. Dismenore sering disertai sakit kepala, mual, sembelit, diare, sering berkemih dan kadang sampai terjadi muntah
- e. Pertambahan umur dan kehamilan akan menyebabkan menghilangnya dismenore primer. Hal ini disebabkan oleh adanya kemunduran saraf rahim karena penuaan dan hilangnya sebagian saraf pada akhir kehamilan.
(Ernawati Sinaga, 2017).

7. Pembagian Klinis Dismenorea

Nyeri merupakan perasaan yang mengganggu kenyamanan akibat suatu hal, keadaan ini hanya dapat dijelaskan oleh penderita nyeri tersebut terkait sebab dan/atau tempat dimana rasa nyeri itu timbul. Secara umum rasa nyeri merupakan perasaan tidak nyaman yang erat kaitannya dengan gangguan tubuh dan faktor lain. Salah satu skala nyeri diantaranya menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) (Ernawati Sinaga, 2017).

Tingkat nyeri di bagian atas skala kategori (tidak nyeri, sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat). Nyeri merupakan keadaan dimana seseorang membuat alasan untuk dirinya mencari bantuan perawatan kesehatan yang menjadi penyebab dari pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan. Nyeri terjadi bersama banyak proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa pemeriksaan diagnostic atau pengobatan.

- a. Ringan : Berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari - hari
- b. Sedang : Diperlukan obat penghilang rasa nyeri, tanpa perlu meninggalkan Pekerjaannya
- c. Berat : Perlu istirahat beberapa hari dan dapat disertai, sakit kepala, sakit Pinggang, diare, dan rasa tertekan

Pembagian klinis dismenore menurut (Calis, 2011 dalam Lestari, 2013) yaitu:

- a. Nyeri spasmodic
Nyeri spasmodik terasa dibagian bawah perut dan berawal sebelum masa haid atau segera setelah masa haid mulai. Banyak perempuan terpaksa harus

berbaring karena terlalu menderita nyeri itu sehingga ia tidak dapat mengerjakan apa pun.

b. Nyeri Kongestif

Penderita dismenore kongestif yang biasanya akan tahu sejak sehari-hari sebelumnya bahwa masa haidnya akan segera tiba. Mereka mungkin akan mengalami pegal, sakit pada buah dada, perut kembung tidak menentu, beha terasa terlalu ketat, sakit kepala, sakit punggung, pegal pada paha, merasa lelah, mudah tersinggung, kehilangan keseimbangan, terganggu tidur.

(Laelika Ramadanti, 2022).

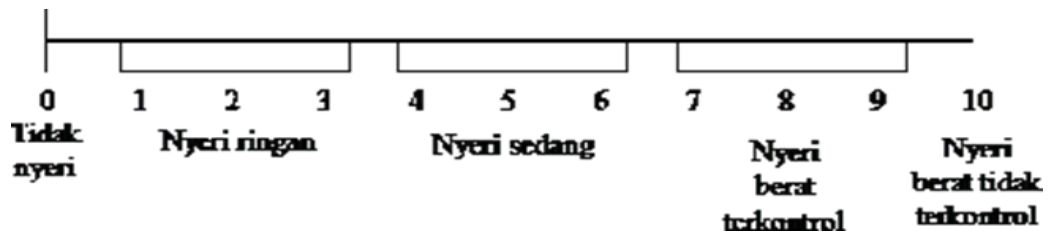
8. Pengukuran Intensitas Dismenorea

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan oleh individu. Pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual dan kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun, pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Nuraisyah Hutagalung, 2022).

Karakteristik paling subyektif pada nyeri adalah tingkat keparahan atau intensitas nyeri tersebut. Klien seringkali diminta untuk mendeskripsikan nyeri sebagai yang ringan, sedang atau parah. Namun, makna istilah-istilah ini berbeda bagi perawat dan klien. Dari waktu ke waktu informasi jenis ini juga sulit untuk dipastikan.

a. Skala Intensitas nyeri deskritif

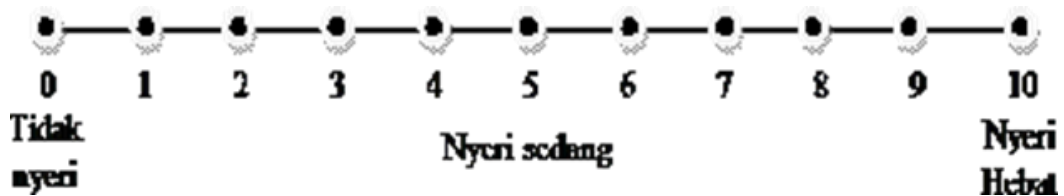
Skala deskritif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih obyektif. Skala pendeskripsi verbal (Verbal Descriptor Scale, VDS) merupakan sebuah garis yang terdiri dari tiga sampai lima kata pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama di sepanjang garis. Pendeskripsi ini diranking dari “tidak terasa nyeri” sampai “nyeri yang tidak tertahankan”. Perawat menunjukkan klien skala tersebut dan meminta klien untuk memilih intensitas nyeri terbaru yang ia rasakan. Perawat juga menanyakan seberapa jauh nyeri terasa paling menyakitkan dan seberapa jauh nyeri terasa paling tidak menyakitkan. Alat VDS ini memungkinkan klien memilih sebuah kategori untuk mendeskripsikan nyeri.



Gambar 6.1

b. Skala identitas nyeri numeric

Skala penilaian numerik (Numerical rating scales, NRS) lebih digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, klien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi terapeutik. Apabila digunakan skala untuk menilai nyeri, maka direkomendasikan patokan 10 cm.



Gambar 6.2

c. Skala analog visual

Skala analog visual (Visual analog scale, VAS) tidak melebel subdivisi. VAS adalah suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi keparahan nyeri. VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian dari pada dipaksa memilih satu kata atau satu angka (Laelika Ramadanti, 2022).



Gambar 6.3

Keterangan dari skala nyeri diatas adalah sebagai berikut :

- 0 : Tidak nyeri
- 1 – 3 : Nyeri ringan (klien dapat berkomunikasi dengan baik)
- 4 – 6 : Nyeri sedang (klien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri,
dapat Mendeskripsikannya dapat mengikuti perintah dengan baik.
- 7 – 9 : Nyeri berat (klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi).
- 10 : Nyeri sangat hebat (klien tidak mampu berkomunikasi dan memukul).

D. Senam Dismenorea

1. Pengertian

Senam Dismenore adalah teknik relaksasi yang dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Dengan relaksasi ini maka tubuh akan banyak memproduksi endorphen. Hormon endorphen adalah senyawa neuropeptida opiloid yang dihasilkan tubuh yang membuat tubuh menjadi rileks. Tidak hanya hormone endorphen yang dihasilkan tubuh namun hormon serotonin juga memproduksi senyawa yang berperan penting pada tubuh karena hormon ini memperbaiki suasana hati, membuat relaks pada tubuh (Yeti Trisnawati & Putri, 2021). Endorphen dihasilkan otak dan susunan saraf tulang belakang. Hormon endorphen ini merupakan obat alami yang dimiliki tubuh sebagai penenang yang diproduksi otak untuk memberikan rasa nyaman dan dapat mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Senam juga akan memperlancar aliran darah saat dismenore (Yeti Trisnawati, 2020).

Senam dismenore adalah senam yang dilakukan untuk membantu peregangan pada otot perut, panggul dan pinggang yang dapat memberikan perasaan nyaman dan mengurangi nyeri menstruasi. Senam dismenore dilakukan secara teratur dengan memperhatikan kontinuitasnya, frekuensi sebaiknya di lakukan 3-4 kali dalam satu minggu atau 5-7 hari sebelum menstruasi, durasi yaitu 30-45 menit setiap kali melakukan senam (Clara Wulanda, 2020). Selain hal tersebut senam dismenore dilakukan dengnan waktu yang tepat yaitu setiap pagi hari karena konsentrasi endophrin terendah di temukan pada saat sore hari dan tertinggi pada saat malam hari (Listyana Natalia R, 2022).

Senam dismenore merupakan aktifitas fisik berupa gerakan-gerakan yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada saat haid. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, aktifitas fisik dinilai cukup apabila dilakukan

selama 30 menit setiap hari atau 3-5 hari dalam satu minggu. Gerakan senam ini bukanlah aerobik, sehingga dapat dilakukan sendiri dirumah. Wanita yang berolahraga atau melakukan aktifitas fisik sekurang kurangnya satu kali seminggu dapat menurunkan intensitas rasa nyeri dan ketidaknyamanan pada bagian bawah abdominal. Pada wanita yang aktif secara fisik dilaporkan jarang mengalami dismenore. Ini dapat dikarenakan oleh adanya hormone endorphen. Hormon ini berfungsi sebagai obat penenang alami, sehingga menimbulkan rasa nyaman, bahkan memiliki efek analgesic (Lilis Fatmawati, 2018).

Senam menjadi salah satu olahraga yang sangat populer sangat ini dan aman untuk dilakukan. Selain itu tidak dibutuhkan proses produksi khusus (tanaman herbal, obat dll) untuk mendapatkannya, hanya perlu semangat dan niat untuk menggerakkan tubuh. Akan tetapi, masalahnya masih sedikit metode yang mendukung gerakan senam dalam upaya menurunkan nyeri dismenore. Untuk itulah perlu disusun sebuah gerakan senam yang bertujuan untuk menurunkan nyeri dismenore yang aman (Chandrayani & Irne Wida Desiyanti, 2022).

Senam dismenore merupakan salah satu bentuk relaksasi yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan saat melakukan olahraga atau senam, tubuh akan menghasilkan hormone endorphen. Endorphine dihasilkan oleh otak dan susunan saraf tulang belakang. Hormon ini berperan sebagai obat penenang alami yang diproduksi oleh otak sehingga menimbulkan rasa nyaman. Tujuan dilakukan senam dismenore adalah untuk mengurangi derajat nyeri dismenore. Adapun manfaatnya antara lain dapat meningkatkan mental dan relaksasi fisik, meningkatkan perkembangan kesadaran tubuh, mengurangi ketegangan otot (kram), mengurangi nyeri otot, dan mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi yang biasa disebut dismenore (Ida Nurjanah, 2019).

2. Manfaat Senam Dismenorea

Manfaat senam dismenore tentunya dapat mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Selain itu senam dismenore juga mengurangi ketegangan otot, meringankan dan menangani terjadinya dismenore, memperlancar aliran darah pada sekitar otot rahim bila dilakukan secara benar maka senam dismenore efektif dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri saat dismenore (Clara Wulanda, 2020).

Manfaat melakukan senam dismenore adalah mengurangi ketegangan otot, memperbaiki peredaran darah, mengurangi kecemasan dan perasaan tertekan, mengurangi kelelahan, serta membuat perasaan menjadi lebih baik. Latihan fisik senam juga dapat meningkatkan kadar hormone endorphen di dalam darah empat sampai lima kali. Hormone endorphen yang diproduksi oleh kelenjar pitutari dapat berfungsi menjadi analgesik dengan cara berikatan dengan

reseptor opioid pada kedua pre dan post sinaps terminal saraf yang dapat menghambat transmisi nyeri. Selain itu, hormone endorphin menghambat pelepasan gamma-aminobutric acid. Penghambatan tersebut dapat meningkatkan produksi dopamine yang berhubungan dengan rasa senang dan relaks (Mariza & Lazary, 2022).

Latihan senam yang dilakukan pada saat dismenore dapat menolong otototot yang mengalami ketegangan agar menjadi relaks. Otot-otot uterus yang mengalami ketegangan saat dismenore saat diberikan latihan tubuh atau senam yang terfokus pada bagian panggul, menyebabkan otot-otot uterus yang tegang mengalami relaksasi dan nyeri pun berangsur-angsur berkurang. Saat melakukan senam seseorang menjadi lebih nyaman, gembira, dan dapat melancarkan perputaran oksigen ke otot. Selain itu aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kadar progesterone. Progesteron akan berinteraksi dengan again otak tertentu yang terkait relaksasi. Belum ada aturan pasti untuk waktu dan frekuensi pelaksanaan latihan fisik. Namun, dengan melakukan olahraga latihan fisik secara rutin dan teratur, maka intensitas nyeri akan semakin berkurang karena jumlah dan ukuran pembuluh darah akan meningkat dan akan mengalirkan darah keseluruh tubuh, termasuk ke organ reproduksi, sehingga nyeri haid dapat berkurang (Yeti Trisnawati, 2020).

Gerakan senam dismenore dilakukan dengan beberapa gerakan senam seperti latihan melemaskan otot punggung yang kaku, latihan menguatkan otot punggung & perut, latihan menguatkan otot perut & punggung, latihan menguatkan otot perut & melemaskan otot pinggul, latihan menguatkan & melemaskan otot perut, punggung, pinggul dan lutut. Gerakan ini dapat dilakukan secara mandiri, berkelompok atau dengan bantuan instruktur. Dengan kita senam tubuh akan menghasilkan hormon endorfin yang dihasilkan di otak dan sum – sum tulang belakang. Hormon endorfin berfungsi sebagai obat penenang alami sehingga menimbulkan rasa nyaman. Hormon Endorphin yang semakin tinggi akan menurunkan atau meringankan nyeri yang dirasakan seseorang sehingga seseorang menjadi lebih nyaman, gembira, dan melancarkan pengiriman oksigen ke otot (Wella Anggraini, 2022).

Tujuan senam disemenore yaitu: (1) membantu remaja yang mengalami dismenore untuk mengurangi dan mencegah dismenore, (2) alternatif terapi dalam mengatasi dismenore, (3) intervensi yang dapat diterapkan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan bagi remaja dengan masalah dismenore, (4) memberikan pengalaman baru bagi remaja (Mariza & Lazary, 2022).

3. SOP Melakukan Senam Dismenorea

SOP (Standar Operasional Prosedur) senam dismenorea sebagai berikut:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	SENAM DISMENOEA
Pengertian	Senam dismenore merupakan gerakan senam untuk membebaskan rasa nyeri haid.
Tujuan	Sebagai pedoman kepada instruktur/tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pemandu senam dalam memberikan terapi nonfarmakologi (senam) kepada klien dengan nyeri dismenore.
LANGKAH – LANGKAH	
GERAKAN PEMANASAN	
	Menekuk lengan tangan kedepan dengan 2x8 hitungan
	Kedua tangan ditekuk keatas dengan hitungan 2x8 hitungan
	Kedua tangan ditekuk kebawah dengan hitungan 2x8 hitungan

	Tangan menekuk sambil memegang telinga kanan dengan hitungan 2x8 hitungan
	Tangan menekuk sambil memegang telinga kiri dengan hitungan 2x8 hitungan
	Kedua tangan dipinggang dan kepala menengadah keatas dan kebawah dengan hitungan 2x8 hitungan
	Kedua tangan dipinggang dan kepala menoleh kekanan dan kekiri dengan hitungan 2x8 hitungan

	Kedua tangan dipinggang dan kepala memiringkan kekiri dan kekanan dengan hitungan 2x8 hitungan
	Kedua tangan lurus dan kaki jijit naik turun dengan hitungan 2x8 hitungan
GERAKAN INTI	
	Merentangkan kedua tangan kemudian ditangan diarahkan kekaki dengan cara menyilang bergantian antara kiri dan kanan dengan hitungan 2x8 hitungan
	
	Kedua tangan keatas dengan posisi badan miring ke kanan dan kekiri kemudian ayunkan tangan kearah atas dengan salah satu kaki ditekuk selama 2x8 hitungan



**Badan membungkuk,
tangan dibawah,
kemudian jongkok
dan kembali tangan di pinggang**



**Badan membungkuk,
tangan dibawah,
kemudian jongkok
dan kembali tangan di pinggang**



**Badan membungkuk,
tangan dibawah,
kemudian jongkok
dan kembali tangan di pinggang**



GEREKAN PENDINGINAN	
	Kedua tangan dipinggang dengan kaki kanan dan kiri diangkat kearah samping dengan hitungan 2x8 hitungan
	
	Kedua tangan di atas lutut, badan mengarah kesamping kanan dan kiri kemudian salah satu kaki menekuk dengan 2x8 hitungan
	Kedua tangan diayunkan keatas dan tarik nafas serta hembuskan melalui mulut dengan 2x8 hitungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Astuti, D., Zayani, N., Maulidia Septimar, Z., & Yatsi Tangerang, Stik. (2021). EFEKTIVITAS SENAM DISMENORE TERHADAP PENANGANAN NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI DI KELURAHAN ALAM JAYA KOTA TANGERANG The. *Nusantara Hasana Journal*, 1(2), 56–66.
- Ayu Idaningsih dan Fitri Oktarini. (2020). PENGARUH EFEKTIVITAS SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI DISMENORE PADA REMAJA PUTRI DI SMK YPIB MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5(No. 2, p-ISSN: 2541-0849, e-ISSN: 2548-1398), 55–66.
- Baiq Nursyahrani Pajriatussani, Y. I. (2022). EVEKTIFITAS TERAPI SENAM DISMINORE DAN KOMPRES HANGAT DALAM MENGURANGI NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, Volume 13(No. 2, P-ISSN 2087-4154 E-ISSN 2774-8669), 38–42.
- Chandrayani, M. H. R., & Irne Wida Desiyanti. (2022). PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI. *Jurnal Sains Dan Kesehatan (JUSIKA)*, 6, 7–11.
- Clara Wulanda, A. L. R. H. (2020). EFEKTIFITAS SENAM DISMENORE PADA PAGI DAN SORE HARI TERHADAP PENANGANAN NYERI HAID PADA REMAJA PUTRI SAAT HAID DI SMPN 2 BANGKINANG KOTA TAHUN 2019. *JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI*, VOLUME 1(NO 1), 1–11.
- Domas Nurchandra Pramudianti. (2022). EFEKTIVITAS SENAM DYSMENORRHEA TERHADAP NYERI DYSMENORRHEA PADA MAHASISWA TINGKAT IV PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, Volume 11(No. 2, p-ISSN: 2338-2139 e-ISSN: 2622-3457), 136–142.
- DWI APRIANI, D. A. (2021). PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN DISMENORE PADA REMAJA PUTRI. *Jurnal Kesehatan*, Volume 10(No. 1).
- Ernawati Sinaga, N. S. S. N. S. U. S. Y. A. M. A. T. S. L. (2017). *Manajemen Kesehatan Menstruasi*. Universitas Nasional IWWASH Global One.
- Hasrawati. (2022). Efektivitas Senam Dismenore dan Endorphin Massage dalam Menurunkan Rasa Nyeri Dismenore Primer pada Remaja Putri. *OPEN ACCESS JAKARTA JOURNAL OF HEALTH SCIENCES*, Vol. 01(P-ISSN 2798-2033, E-ISSN 2798-1959, DOI 10.53801/oajjhs. V 1i10.83), 357–364.
- Ida Nurjanah, Y. M. F. I. (2019). *PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN NYERI MENSTRUASI PADA MAHASISWI ASRAMA STIKes MUHAMMADIYAH PALEMBANG*. Volume. 10(No. 1), 56–62.
- IMA PURNAMA SARI. (2019). *APLIKASI SENAM DISMENORE UNTUK MENGATASI NYERI AKUT PADA REMAJA PUTRI*.

- Laelika Ramadanti. (2022). *APLIKASI SENAM DISMENORE PADA Nn. S UNTUK MENGATASI MASALAH NYERI AKUT (DISMENORE)*.
- Lilis Fatmawati, D. F. L. (2018). EFEKTIFITAS SENAM DISMENORE DAN TEKNIK EFFLEURAGE TERHADAP PENURUNAN DISMENORE PADA REMAJA. *Journal Of Coummunity, Volume 09*(Nomor 02), 147–155.
- Listyana Natalia R, M. W. O. E. L. (2022). PENGARUH SENAM DISMENORE TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI DISMENORE REMAJA PUTRI DI SMA SANATA KARYALANGGUR. *Jurnal Kesehatan*, 162–167.
- Mahmudah. (2020). *LITERATUR REVIEW TENTANG EFEKTIVITAS SENAM RINGAN DISMENORE TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI HAID*.
- Mariza, A., & Lazary, A. (2022). Pengaruh Senam Disminore Terhadap Penurunan Nyeri Disminore Pada Remaja Putri. *Malahayati Nursing Journal*, 4(6), 1600–1607. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i6.5879>
- Merry. (2020). *EFEKTIVITAS SENAM DISMENORE DALAM MENURUNKAN TINGKAT NYERI: SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIS*.
- Nur Partiw, S. M. M. (2021). Efektivitas Senam Dismenore Dan Abdominal Stretching Exercise Terhadap Intensitas Nyeri Haid Pada Remaja Dismenore Primer. *Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan, Vol. XIV* (No. 1, ISSN: 2356-1068).
- Nuraisyah Hutagalung, T. S. Y. V. (2022). Pengaruh Senam Dismenore Dan Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Haid (Dismenore) Pada Remaja Putri Di Sma N 1 Sorkam Barat. *Jurnal Kesehatan Dan Masyarakat (Jurnal KeFis), Volume 2*(No. 2, e-ISSN: 2808-6171), 59–65.
- Nurmala Djimbula, J. J. K. Y. A. (2022). Efektivitas Senam Dismenore dan Musik Klasik Terhadap Penurunan Dismenore Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Volume 11*(Nomor 1, e-ISSN: 2654-4563 dan p-ISSN: 2354-6093).
- Nurmala Muthiah Azhari. (2021). *PENERAPAN SENAM DISMENORE PADA REMAJA PUTRI DENGAN DISMENORE*.
- Roihatul Zahroh, I. N. N. L. (2020). PENGARUH SENAM DISMENORRHEA DAN SENAM AEROBIC LOW IMPACT TERHADAP NYERI HAID (DISMENORRHEA) PADA REMAJA AWAL. *Journals Of Ners Community, Volume 11*(Nomor 01), 18–27.
- Rya Anastasya Siregar. (2021). Penyuluhan dan Senam Disminore pada Anak Remaja Putri DI Desa Joring Natobang Kecamatan Angkola Julu Padangsidimpuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA), Volume 3*(No. 1), 5–12.
- Sasi Sri Parhanah, H. R. (2021). Penerapan Senam Dismenore Untuk Penurunan Rasa Nyeri Saat Menstruasi Dikelurahan Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 2003–2008.

- Sitohang, N. A., & Nasution, D. L. (2021). Pengetahuan dan Sikap Remaja Anak Jalanan tentang Dismenore Primer dan Senam Dismenore di Komunitas Peduli Anak Jalanan Medan. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v6i2.249>
- Wella Anggraini. (2022). PENGARUH SENAM DISMENOREA TERHADAP TINGKAT NYERI DISMENOREA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BAKTI UTAMA PATI. In *Journal of TSCNers* (Vol. 7, Issue 2). <http://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCNers>.
- Yeti Trisnawati, A. M. (2020). Pengaruh Latihan Senam Dismenore terhadap Penurunan Nyeri Dismenore pada Mahasiswa Kebidanan. *Gorontalo Journal of Public Health*, Volume 3 (No. 2, P-ISSN: 2614-5057, E-ISSN: 2614-5065), 71–79.
- Yeti Trisnawati, & Putri, N. A. (2021). IMPLEMENTASI SENAM DISMENORE UNTUK MENGURANGI NYERI MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI DI POSYANDU LAVENDER KELURAHAN BATU IX. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Anugerah Bintang (JPMAB)* (Vol. 2, Issue 01).

BAB VII

**PREVENSI PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA
REMAJA MELALUI PENDIDIKAN SEKSUALITAS
KOMPREHENSIF
(CURRICULUM SEXUALITY EDUCATION)**

Machria Rachman, SST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

PREVENSI PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA REMAJA MELALUI PENDIDIKAN SEKSUALITAS KOMPREHENSIF (*CURRICULUM SEXUALITY EDUCATION*)

Machria Rachman, SST., M.Kes

A. Pendahuluan

Masa remaja adalah fase transisi dari anak-anak menuju dewasa. Perkembangan remaja secara fisik maupun psikologis sangat pesat termasuk pula proses tumbuh kembang reproduksi yang mengatur fungsi seksualitas. Secara fisik, perubahan bentuk dan fungsi tubuh mulai ditandai munculnya tanda seks sekunder. Pada remaja perempuan, terjadi *menarche* yaitu haid pertama kali. Sedangkan remaja laki-laki mengalami mimpi basah saat pubertas. Remaja mulai muncul dorongan seksual, menyukai lawan jenis dan juga mengekspresikan hasratnya dengan berperilaku seksual. Sayangnya, perkembangan fisik tersebut belum disertai dengan kemampuan mental-kognitif dan psikis yang matang, sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, pengaruh lingkungan negatif menyebabkan remaja rentan mengalami berbagai masalah diantaranya: perilaku seks berisiko seperti seks bebas (seksualitas), HIV-AIDS dan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza), yang dikenal *triad KRR*.

Isu kesehatan reproduksi remaja (KRR) menjadi fokus penting dunia global dengan memuat *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 10-14 sebagai salah satu indikator capaian *Sustainable Developmental Goals* (SDG's) (Bappenas, 2020). Di dunia, hasil estimasi ASFR 10-14 adalah 0,81 yang berarti terdapat 81 kelahiran pada perempuan usia 10-14 tahun (Gustina, 2020). Sedangkan angka kehamilan remaja di Indonesia sebesar 47,4 per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun (WHO, 2022). KRR juga menjadi poin penting dalam upaya Indonesia dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Di Indonesia, jumlah remaja (usia 10 – 24 tahun) sebesar 67 juta jiwa atau 24, % dari total penduduk Indonesia, sehingga remaja menjadi sumberdaya potensial dalam pembangunan nasional. Data survei SDKI Tahun 2017 menunjukkan 8% remaja laki-laki dan 1% remaja perempuan pernah melakukan hubungan seksual (BPS, 2018). Sebanyak 16,3% perempuan menikah di usia kurang dari 18 tahun (WHO, 2022). Hal ini dapat dipicu oleh faktor pengetahuan komprehensif tentang kesehatan reproduksi yang rendah dan peningkatan perilaku berisiko pada remaja seperti: seks bebas, kehamilan tidak diinginkan pada remaja, aborsi tidak aman, dan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV-AIDS. Dari studi GEAS menunjukkan hanya 41,6% remaja perempuan menjawab benar bahwa perempuan dapat hamil setelah melakukan hubungan seksual pertama kali, dan

31,1% mengerti bahwa remaja dapat tertular HIV setelah melakukan hubungan seksual pertama kali (Rutgers, 2020).

Setiap remaja hendaknya mengenali perubahan fisik dan psikis yang dialaminya, termasuk dorongan seksual, dengan mendapatkan informasi yang tepat dan adekuat. Faktanya, “membicarakan tentang seks” masih dianggap tabu di budaya kita apalagi jika diperbincangkan oleh remaja. Seringkali sumber informasi tentang seksualitas didapatkan dari temannya dan sumber lain yang mengandung konten pornografi. Acapkali orang tua juga risih membahas tentang pendidikan seksualitas pada anaknya dan belum memahami benar informasi dan kebutuhan yang sesuai bagi remaja. Kadangkala ketakutan muncul jika remaja terpapar informasi tentang seksualitas dapat meningkatkan permisivitas dalam perilaku seksual tidak aman. Padahal, akan lebih berbahaya akibatnya apabila mereka mendapatkan informasi keliru dari sumber yang tidak relevan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang menyeluruh bagi remaja (Rutgers, 2020).

B. Seksualitas pada Remaja

1. Pengertian Seks, Seksual, Seksualitas dan Kesehatan Seksual

Istilah seks, seksual dan seksualitas masih menimbulkan banyak keragaman penafsiran di masyarakat. Secara terminologis, **seks** berarti jenis kelamin. Seks menjelaskan ciri jenis kelamin secara anatomi dan fisiologi pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis atau bersifat kodrati dan sudah melekat pada masing-masing individu sejak lahir. **Seksual** dapat diartikan segala sesuatu tentang jenis kelamin (seks); berkenaan dengan insting, proses fisiologis, dan aktifitas berhubungan fisik atau kontak intim antara individu (IAC, 2012). Definisi **seksualitas** adalah hal yang berhubungan dengan seks dan seksual. Menurut WHO, seksualitas adalah aspek sentral dari keberadaan manusia sepanjang hidup yaitu mencakup jenis kelamin, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi. Seksualitas merupakan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada orang lain melalui tindakan yang dilakukannya seperti sentuhan, pelukan, ataupun perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerak tubuh, cara berpakaian, dan perbendaharaan kata, termasuk pikiran, pengalaman, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang luas, baik faktor biologis, psikologis, sosial, kultural moral, politik, hukum, sejarah, agama dan spiritual yang mempengaruhi individu dalam bermasyarakat (WHO, 2015).

Kesehatan seksual adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, emosional, dan sosial yang berhubungan dengan seksualitas, bukan hanya tidak terkena penyakit, gangguan atau kelemahan. Kesehatan seksual mencakup faktor multidimensi yang dinamis serta mengalami perubahan dalam identifikasi manusia sebagai makhluk seksual yang unik, termasuk aspek : persepsi diri, ekspresi seksualitas, sistem nilai dan keyakinan seksual, sikap seksual, perilaku seksual dan persepsi “seks”. Hal ini membutuhkan pendekatan positif dan penghargaan mendapatkan pengalaman yang positif terkait hubungan seksualitas dan seksual, seperti pengalaman seksual yang aman, memuaskan, tanpa diskriminasi, paksaan maupun kekerasan (Bowden, 2017).

2. Dimensi Seksualitas

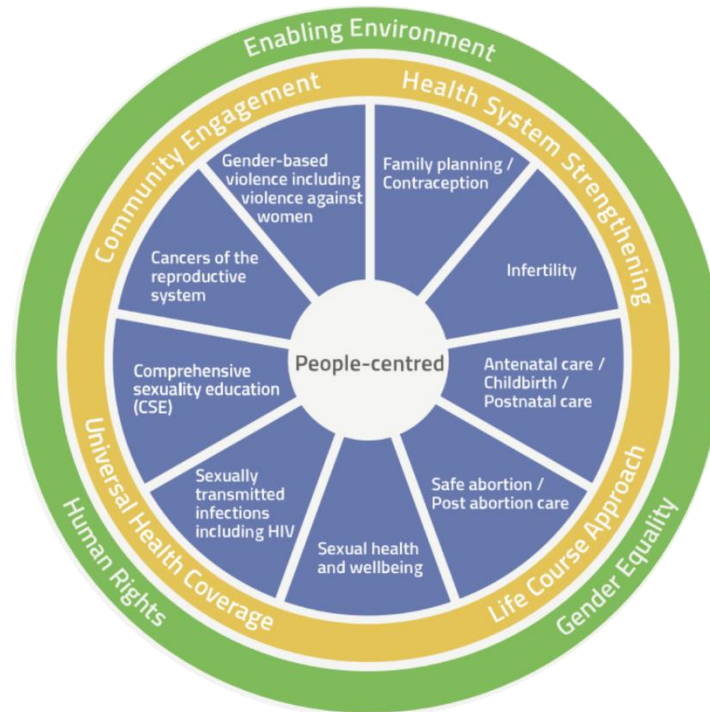
Seksualitas memiliki dimensi yang luas, diantaranya dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural moral. Seksualitas dilihat dari **dimensi biologis** mengacu pada organ reproduksi dan genital, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan fungsi organ genital dan hasrat seksual secara optimal. Dari **dimensi psikologis**, seksualitas terkait erat dengan bagaimana individu berperilaku sebagai makhluk seksual, yaitu menjalankan peran sesuai identitas jenis kelamin, dan bagaimana dinamika aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) mempengaruhi seksualitas itu sendiri. Misalnya: seorang laki-laki berperilaku sesuai identitas seksual, peran seksual sebagai laki-laki demi kepuasan psikologisnya. **Dimensi sosial** melihat bagaimana seksualitas memanifestasikan dirinya dalam hubungan manusia, bagaimana pengaruh lingkungan mempengaruhi pandangan tentang seksualitas, yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual. **Dimensi budaya** menunjukkan bagaimana nilai-nilai kultural dan moral memandang seksualitas, serta perilaku seksual merupakan bagian dari budaya masyarakat (PKBI, 2016).

3. Hak-hak Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Seksual Remaja

Hak seksual dan reproduksi termasuk dalam hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak-hak tersebut, tak terkecuali pada remaja. Semua individu memiliki hak untuk membuat pilihan tentang tubuh mereka sendiri dan menggunakan layanan yang mendukung hak tersebut. Secara garis besar, Hak seksual dan reproduksi termanifestasi pada hak asasi manusia setiap individu untuk:

- a) Menghormati integritas tubuh, privasi, dan otonomi pribadi mereka
- b) Bebas mendefinisikan orientasi seksual mereka sendiri, serta identitas dan ekspresi gender
- c) Membuat keputusan apakah dan kapan harus aktif secara seksual;
- d) Memilih pasangan seksual mereka;
- e) Mendapatkan pengalaman seksual yang aman dan menyenangkan;

- f) Memutuskan apakah, kapan dan siapa yang akan dinikahi;
- g) Memutuskan apakah, kapan dan dengan cara apa mempunyai anak, dan jumlah anak yang akan dimiliki;
- h) Mendapatkan informasi, sumber daya, layanan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai semua hal tersebut di atas sepanjang siklus kehidupan tanpa diskriminasi, paksaan, eksploitasi maupun kekerasan.



Gambar 7.1. Elemen dan Realisasi *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR)

Implementasi dari pemenuhan hak seksual dan reproduksi pada remaja menurut ICPD25, yaitu remaja dapat mengakses layanan sebagai berikut:

- a) Pendidikan seksualitas komprehensif, baik di sekolah maupun di luar sekolah
- b) Informasi, konseling, dan layanan kesehatan seksual dan kesejahteraan
- c) Pencegahan, deteksi, dan manajemen keganasan sistem reproduksi, terutama kanker serviks
- d) Layanan aborsi aman dan penanganan komplikasi aborsi yang tidak aman
- e) Pencegahan, deteksi, pelayanan segera, dan rujukan untuk kasus-kasus kekerasan seksual dan berbasis gender
- f) Pencegahan dan pengobatan HIV dan infeksi menular seksual lainnya
- g) Konseling dan layanan untuk berbagai kontrasepsi modern, dengan jumlah minimum dan jenis metode yang ditentukan.

(UNFPA, 2019)

4. Perkembangan Seksualitas Remaja

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk seksual. Sistem reproduksi manusia memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian spesies manusia, mengekspresikan aspek seksualitas, serta membentuk dan mempertahankan karakteristik seks sekunder. Perkembangan seksualitas bukan hanya manifestasi dari pemuasan kebutuhan seksual, namun juga membentuk identitas, nilai, perasaan, sikap, interaksi dan perilaku manusia sepanjang daur hidupnya. Dalam prosesnya, manusia mengalami perkembangan seksualitas seperti berikut:

a) Perkembangan Seksualitas Prenatal dan Masa Bayi

Perkembangan seksual terbentuk sejak dalam kandungan yaitu pada masa organogenesis atau pertumbuhan dan perkembangan organ pada embrio. Pada minggu ke 10 kehamilan, terjadi diferensiasi seksual pada alat kelamin, yaitu penentu apakah janin berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang dipengaruhi oleh konfigurasi genetik dan hormon-hormon. Pada genitalia janin laki-laki mulai terbentuk penis, lipatan uretra yang sebagian menyatu, serta terdapat tonjolan genital berupa skrotum. Pada genitalia perempuan, klitoris sedang terbentuk, terdapat lipatan uretra dan tonjolan genital berbentuk labia. Perkembangan seksual ini berlanjut hingga memasuki akhir kehamilan (aterm) yaitu alat genitalia laki-laki dan perempuan telah terbentuk sempurna. Setelah lahir, bayi memiliki kapasitas kesenangan dan respon seksual dimana area genital sensitif terhadap sentuhan, seperti bayi perempuan mengeluarkan lendir dari vagina, sedangkan pada bayi laki-laki penisnya erektile dan terjadi ereksi nokturnal secara spontan meski tanpa stimulasi sentuhan. Rangsangan pada indera perabaan seperti menyentuh, memeluk, membuai, dan menyusui dapat membangun pengalaman kenyamanan dan kesenangan bayi, yang berpengaruh terhadap perkembangan identitas diri positif pada bayi (Bobak, 2012).

b) Perkembangan Seksualitas pada Masa Anak

Anak-anak usia 3-4 tahun mulai memahami identitas gender, sebagai laki-laki atau perempuan. Seringkali mereka mulai suka menyentuh alat kelamin sendiri dan timbul keingintahuan merasakan bagian tubuh teman bermainnya. Di usia 5-7 tahun, anak mulai menjelajahi peran orang dewasa dengan bermain peran, serta cenderung menjalin kedekatan dengan orangtua dengan jenis kelamin yang sama. Di usia ini, anak-anak mulai mengerti perbedaan jenis kelamin namun belum tertarik dengan lawan jenis. Usia 8-12 tahun, anak-anak mulai mengalami perubahan fisik mendekati pubertas. Mereka mulai menjauh dari orangtua dan menginginkan privasi.

c) Perkembangan Seksualitas pada Masa Remaja

Remaja mengalami pubertas, yaitu ditandai dengan adanya tanda-tanda seks sekunder contohnya pada perempuan, pinggul melebar, payudara membesar, tumbuh bulu ketiak dan rambut kemaluan. Tanda seks primer juga terjadi pada masa ini, yaitu pada laki-laki mengalami *nocturnal emission* atau mimpi basah, sedangkan remaja perempuan mengalami menstruasi pertama kali (*menarche*). Secara psikologis, rasa penasaran remaja terhadap hal baru termasuk perkara seksualitas sangat tinggi, didukung pula dengan telah timbul hasrat seksual pengaruh hormon-hormon seksual yang meningkat saat pubertas. Perubahan fisik dan psikologis yang drastis mempengaruhi remaja untuk mencari pengetahuan tentang seks dan mengekspresikan hasrat seksualnya dengan melakukan pacaran. Perkembangan remaja yang belum disertai matangnya kognitif menyebabkan remaja belum dapat mengambil keputusan bertanggungjawab sehingga rawan melakukan perilaku berisiko termasuk perilaku seksual pranikah (Imran, 2016).

5. Perilaku Seksual Remaja

Perilaku seksual adalah perilaku yang didasari oleh hasrat seksual atau hal yang menimbulkan kesenangan pada organ seksual, contohnya berpegangan tangan, berciuman, berfantasi, masturbasi, berpelukan, *petting*, dan berhubungan badan. Masalah seksual yang sering terjadi pada remaja karena hasrat seksual yang meningkat namun dihadapkan dengan kondisi belum menikah atau tidak diperbolehkan berhubungan seksual karena tuntutan sosial. Kematangan biologis di usia remaja nyatanya tidak diimbangi kematangan psikososial dalam mempertimbangkan risiko, manajemen nafsu seksual dan pengambilan keputusan yang matang. Hal ini mempengaruhi remaja dalam memanifestasikan perilaku seks berisiko yaitu coba-coba berhubungan seksual bahkan hingga kecanduan seks. Beberapa faktor yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku seksual antara lain: pengalaman seksual; faktor internal (nilai diri, kontrol diri, harga diri, koping stress, keterampilan *decision making*, tanggungjawab); pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan; Fungsi keluarga sebagai fungsi komunikasi, kasih sayang dan penanaman nilai moral; dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi (Imran, 2016)

C. Pendidikan Seksualitas Komprehensif bagi Remaja

1. Pengertian dan Tujuan

Pendidikan seksualitas komprehensif (*Curriculum Sexuality Education* atau CSE) bukan sekedar menyampaikan informasi tentang sistem reproduksi remaja (*sex education*), namun memiliki makna lebih menyeluruh. Pendidikan

seksualitas komprehensif merupakan proses pendidikan dan pembelajaran berbasis kurikulum mengenai aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial terkait seksualitas. Pendidikan ini bertujuan membekali remaja dengan pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai pemberdayaan diri agar sadar akan kesehatan, kesejahteraan dan martabat mereka; mempertimbangkan pilihan yang dapat memengaruhi kesejahteraan diri sendiri maupun orang lain; mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang saling menghormati; serta memahami dan memastikan hak-hak reproduksi sepanjang hidup mereka terlindungi (WHO, 2018).

2. Komponen Pendidikan Seksualitas Komprehensif

Menurut *International Planned Parenthood Federation* (IPPF), CSE mencakup tujuh komponen meliputi:

a) Gender

Remaja perlu memahami perbedaan antara *sex* (jenis kelamin) dan *gender*. Seks adalah pembeda laki-laki dan perempuan secara biologis, sedangkan gender merupakan pembeda peran laki-laki dan perempuan hasil dari konstruksi sosial. Dalam bahasan gender, remaja memahami persepsi maskulinitas dan feminitas di dalam lingkup keluarga dan sepanjang siklus kehidupan; dapat mengeksplorasi peran dan atribut gender; perubahan norma dan nilai di masyarakat; perwujudan dan konsekuensi dari bias gender, stereotipe dan ketidaksetaraan gender termasuk stigmatisasi diri.

b) Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi, dan HIV

Dalam materi “Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi, dan HIV” membahas tentang seksualitas dan daur hidup seperti pubertas, masalah seksual, stigma dan menopause; Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi; Cara penggunaan kondom; kontrasepsi; Pilihan dan informasi tentang kehamilan; *Safe abortion and Unsafe Abortion*; Pengetahuan tentang penularan, gejala IMS dan HIV; Pencegahan, layanan dan dukungan IMS dan HIV; Konseling dan tes HIV; Terapi ARV dan hidup dengan HIV (bagi remaja ODHA); Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak; Narkoba suntik dan HIV; Keperawanan; *Abstinensia* (tidak berhubungan seksual); saling setia pada pasangan; Respon seksual; Ekspektasi sosial; Harga diri dan *empowerment*; menghargai tubuh; stereotip dan mitos.

c) Hak seksual dan Hak asasi manusia (HAM)

Pemahaman remaja tentang hak asasi manusia dan hak seksual juga penting. Remaja perlu diberi bekal tentang: pengetahuan tentang HAM, peraturan, kebijakan terkait seksualitas; Pendekatan berbasis hak dalam kesehatan seksual dan reproduksi; Kendala sosial, budaya, dan etik dalam pelaksanaan hak seksual reproduksi; Pengetahuan bahwa seksualitas dan

budaya merupakan suatu keanekaragaman yang dinamis; Ketersediaan layanan dan cara mengakses; Variasi identitas seksual; Norma dan Praktik; Pilihan; Partisipasi; Advokasi; Keterampilan Negosiasi; Persetujuan dan hak berhubungan seksual saat siap; serta hak mengungkapkan seksualitas secara aman, sehat dan menyenangkan.

d) *Pleasure* (Kepuasan)

Hendaknya remaja memiliki sikap positif terhadap seksualitas, memahami bahwa seks selayaknya menyenangkan dan tanpa paksaan; seksualitas adalah bagian dari kehidupan setiap orang bukan hanya berkonotasi hubungan seksual; kesejahteraan seksual; Keragaman Seksualitas; Komunikasi interpersonal; Respon seksual dipandang dari sisi biologi dan emosi, gender dan kepuasan; Praktik seks yang aman dan kesenangan; Cinta, nafsu dan menjalin hubungan; Masturbasi; Pengalaman seksual pertama kali; Persetujuan; Implikasi penggunaan alkohol dan obat-obatan; dan penanganan stigma mengenai kepuasan.

e) Kekerasan

Remaja mengenali berbagai macam kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan, khususnya kekerasan berdasarkan gender; Hak dan Hukum; Pemahaman bahwa hubungan intim dengan paksaan tidak dapat diterima, misalnya: pemerkosaan; Mencari bantuan dan dukungan yang tersedia jika terjadi kekerasan; Mitos dan norma tentang Kekuasaan dan gender; Pencegahan kekerasan, rencana keselamatan diri dan teknik pertahanan diri; Pemahaman dinamika korban dan pelaku kekerasan; Pencegahan korban kekerasan menjadi pelaku; serta Mekanisme rujukan bagi penyintas korban kekerasan.

f) *Diversity* (Keragaman)

Keragaman dalam kehidupan seperti: nilai, keyakinan, status sosial ekonomi, etnis, budaya, kemampuan dan disabilitas, orientasi seksual dan status HIV, perlu dikenali dan dipahami oleh remaja. Sepatutnya, remaja mempunyai pandangan positif tentang keragaman, memahami diskriminasi dan mampu menghadapi dampak buruknya, meyakini kesetaraan, serta mendukung remaja untuk bergerak melampaui toleransi (penerimaan, menghormati, saling pengertian, dan perayaan keanekaragaman).

g) *Relationships* (hubungan)

Dalam membina hubungan, remaja perlu mengerti berbagai tipe hubungan misalnya: keluarga, pertemanan, hubungan mesra, seksual, dll, bahwa suatu relasi tidak statis atau akan selalu berubah; Hubungan melibatkan keintiman baik secara fisik dan emosional; Hak dan tanggungjawab; Pemahaman hubungan yang sehat dan tidak sehat atau

dalam paksaan; Dinamika kekuasaan; Membangun kepercayaan dan kejujuran dalam relasi; Norma sosial dan tekanan sebaya; serta pemahaman bahwa seks dan cinta bukanlah hal yang sama (IPPF, 2010).

3. Evidence Based Practice Penerapan Pendidikan Seksualitas Komprehensif pada Remaja

Studi membuktikan bahwa CSE efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program CSE berpengaruh terhadap penundaan hubungan seksual pertama kali, penurunan jumlah pasangan seksual, penurunan frekuensi hubungan seksual, pengurangan perilaku seksual berisiko, peningkatan penggunaan kondom serta pemakaian alat kontrasepsi. Studi menyatakan tidak ada bukti bahwa *Curriculum Sexuality Education* dapat meningkatkan aktivitas seksual, perilaku seksual berisiko, atau kejadian HIV maupun IMS lainnya (Unesco, WHO, 2018). *Curriculum Sexuality Education* berbasis sekolah juga telah terbukti menjadi upaya pencegahan HIV yang hemat biaya (WHO, 2018).

D. Peran Bidan dalam Asuhan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Remaja

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja termasuk dalam pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang pelaksanaannya tak terlepas dari peran bidan (Kemenkes RI, 2015). Sesuai standar profesi bidan yang termaktub di KMK No. 320 tahun 2020, bahwa kompetensi bidan dalam memberikan asuhan pada masa remaja antara lain: melakukan skrining masalah KRR; Komunikasi, Edukasi dan Edukasi (KIE) dan konseling KRR termasuk edukasi tentang tanda-tanda seks sekunder, *menarche*, pola hidup sehat bagi remaja, dan selaput dara berbasis budaya dan etikolegal; memfasilitasi konselor teman sebaya; memberikan imunisasi sesuai program; serta berkolaborasi dalam tata laksana korban kekerasan fisik dan seksual. Dalam implementasinya, bidan memberikan asuhan secara mandiri, mengembangkan *interprofessional collaboration* sewaktu bekerja dalam tim, serta rujukan. Lingkup kesehatan seksual cukup luas, yakni sepanjang siklus kehidupan perempuan. Dari hasil riset dan bukti subyektif menjelaskan bahwa tanggungjawab profesional bidan sebagai pemberi asuhan primer dalam kesehatan seksual dan reproduksi perempuan (Bowden, 2017). Di tingkat layanan primer, bidan melakukan skrining masalah seksual pada remaja melalui pendekatan anamnesis HEEADDSSS yaitu pada poin (S) *Sexuality*. Pengkajian tentang seksualitas remaja adalah bagian paling sensitif dan membutuhkan persetujuan serta pendekatan khusus. Hal-hal yang perlu dikaji saat menilai kemungkinan remaja memiliki risiko atau masalah seputar aktivitas seksual diantaranya: apakah ada perilaku seksual berisiko atau seks pranikah, kemungkinan terjadi kehamilan, kemungkinan adanya IMS, ataupun

adanya kekerasan seksual pada remaja (Indira, 2019). Apabila remaja mengalami masalah seksual atau berisiko terhadap masalah seksual maka dilakukan penanganan sesuai dengan temuan kasus. Jika diperlukan, melakukan pemeriksaan lanjutan, atau kolaborasi dengan profesional lain (dokter, psikolog atau psikiater, dokter spesialis, ahli gizi, analis kesehatan, dll). Karena remaja belum cukup umur, dalam melakukan anamnesis, tindakan pemeriksaan, dan proses konseling atau KIE perlu dilakukan pendampingan orang dewasa (orang tua, keluarga, kakak, dll), serta *informed consent* (Kemenkes RI, 2018).

Penekanan asuhan remaja oleh bidan terletak pada KIE dan konseling KRR dengan tujuan *preventif dan promotif*. Bidan memiliki posisi yang potensial dalam meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan termasuk remaja, baik bidan yang bekerja mandiri (TPMB), di komunitas (Puskesmas), di klinik maupun rumah sakit. Hal ini dapat dipenuhi dengan bekerja sesuai target program nasional yang dikembangkan terkait KRR, dan selalu meningkatkan inisiatif pengembangan promosi kesehatan reproduksi dan seksual remaja guna meningkatkan pikiran rasional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membangun harga diri, perasaan, sikap dan perilaku seks yang positif (Bowden, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. <https://e-koren.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-SDKI-2017-WUS.pdf>
- Bappenas. 2020. Indonesia Resmi Gunakan ASFR 10-14 Tahun Sebagai Salah Satu Indikator Capaian SDGs. <https://bappenas.go.id/index.php/berita/bappenas-indonesia-resmi-gunakan-asfr-10-14-tahun-sebagai-salah-satu-indikator-capaian-sdgs>
- Bobak, dkk. 2012. Buku Ajar Keperawatan Maternitas, Jakarta : EGC
- Bowden J., Manning V. 2017. *Health Promotion in Midwifery: Principles and Practice, Third Edition*. CRC Press: New York
- Emilia, Ova, Prabandari, Y, dkk. 2018. *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: UGM Press
- Gustina, Eni. 2020. Kebijakan Strategi Kesehatan Reproduksi Remaja. Webinar Series 1: Investasi Publik untuk Kesejahteraan Jangka Panjang Remaja
- Indonesia AIDS Coalition (IAC). 2012. Seks, Seksual dan Seksualitas. <https://www.iac.or.id/id/seks-seksual-dan-seksualitas/>
- Imran, Irawati. 2016. Modul 2: Perkembangan Seksualitas Remaja. PKBI, IPPF, BKKBN, UNFPA
- IPPF. 2010. *IPPF Framework for Comprehensive Sexuality Education (CSE)*. International Planned Parenthood Federation
- Indira. 2019. Konsep pendekatan HEEADSSS dan algoritma pertumbuhan - perkembangan dengan MTPKR di FKTP. Webinar Orientasi Pelayanan PKPR. Direktorat Gizi KIA
- Kemenkes RI. 2018. Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR) di FKTP. Kementerian Kesehatan RI
- Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan
- PKBI. 2016. Modul 2: Perkembangan Seksualitas Remaja. <https://pkbi-diy.info/seksualitas/>
- Rutgers WPF Indonesia. 2020. Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemberdayaan Remaja untuk Masa Depan Terencana, Policy Brief GEAS Indonesia (Issue 1, Vol. 4, July 2020)
- UNESCO. 2018. Revised edition: *International Technical Guidance On Sexuality Education – An Evidence-Informed Approach*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

- UNFPA. 2019. *Sexual and Reproductive Health and Rights: An Essential Element of Universal Health Coverage*. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SRHR_an_essential_element_of_UHC_SupplementAndUniversalAccess_27-online.pdf
- WHO. 2015. *Sexual Health, Human Rights and The Law*. World Health Organization: Switzerland
- WHO. 2018. *WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights*. World Health Organization: Switzerland
- WHO. 2022. *Sexual and Reproductive Health and Rights Infographic Snapshot Indonesia 2021*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/349526/WHO-SRH-21.100-eng.pdf>

PROFIL PENULIS



Feling Polwandari, S.ST., M.Keb.

Penulis merupakan Dosen Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Faletehan. Menyelesaikan program DIII Kebidanan dengan gelar Ahli Madya Kebidanan dan gelar Sarjana Sains Terapan di Stikes Husada, Jombang (2008 dan 2009). Menyelesaikan program Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran, Bandung (2017).

Penulis telah menghasilkan 2 buku sebelumnya dimana topik buku yang ditulis adalah tentang pemberdayaan remaja dengan mengenal perubahan fisiologis otak yang terjadi selama masa remaja serta bagaimana perubahan psikologisnya terjadi selama masa tumbuh kembang remaja dan buku lainnya adalah tentang pembahasan soal uji kompetensi dalam bentuk soal komunitas. Selain buku, penulis juga telah melakukan publikasi terkait remaja baik publikasi tingkat nasional dan internasional.

Penulis terkonsentrasi pada Asuhan Kebidanan pada Remaja dikarenakan menurut penulis remaja adalah masa yang paling tepat untuk melakukan tindakan preventif terhadap risiko yang akan mungkin terjadi pada masa kehamilan sampai persalinan bahkan sampai daur kehidupannya di masa menopause, serta sebagai waktu yang tepat untuk diberikan persiapan menjadi calon orang tua dari sedini mungkin dengan menjaga kesehatan fisik dan psikologis mereka.

PROFIL PENULIS



Devi Endah Saraswati, S.ST., M.Kes

Penulis lahir di Lamongan, Tanggal 30 Agustus 1987. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di AKBID Pemkab Bojonegoro tahun 2008, DIV Bidan Pendidik di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang tahun 2011 dan S2 Magister Sains Terapan Kesehatan (Kebidanan) di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014.

Penulis saat ini aktif sebagai Dosen Prodi Diploma III Kebidanan sejak tahun 2014-sekarang, serta mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Diploma III Kebidanan di Fakultas Kesehatan Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insan Cendekia Husada Bojonegoro sejak tahun 2017-sekarang. Penulis mengajar mata kuliah Konsep Kebidanan, ASKEB Kehamilan, ASKEB Persalinan dan BBL, ASKEB Nifas dan Ibu Menyusui, ASKEB Neonatus, Bayi, Balita, dan APRAS, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Metode Penelitian dan Statistik Dasar. Selain mengajar penulis juga membimbing Tugas Akhir mahasiswa Prodi D III Kebidanan dan SKRIPSI Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Aktif dalam kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Review Jurnal Nasional dan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Pengalaman penulis dalam membuat buku sebelumnya yang berjudul Persepsi dan Stigma Masyarakat Tentang Covid-19 ber ISBN.

Moto Hidup: Karunia Allah yang Paling Lengkap adalah Kehidupan yang Didasarkan pada Ilmu Pengetahuan (Ali bin Abi Thalib). Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: deviendah059@gmail.com

PROFIL PENULIS



Syahridayanti, S. ST., M. Kes, penulis yang lebih akrab di sapa Anty ini lahir di Pattiro Bajo, 12 Mei 1990, merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada prodi D-III Kebidanan dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan program study D-IV Bidan Pendidik di Stikes Abdi Nusantara Jakarta lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan program S-2 Kesehatan Reproduksi di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan lulus pada tahun 2017.

Sejak lulus di D-IV Bidan pendidik, penulis mulai bekerja di STIKes Yapika Makassar pada bagian laboratorium kebidanan. Dan setelah lulus S-2 sampai saat ini penulis telah menjadi dosen tetap di AKBID Menara Bunda Kolaka yang sekarang sudah beralih menjadi INKEIS Menara Bunda Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Saat ini penulis sudah mulai aktif menulis sejak bergabung menjadi anggota di Optimal, salah satu buku yang telah dihasilkan berjudul Promosi Kesehatan Dalam Kebidanan (Nuansa Fajar Cemerlang) dan akan segera menyusul buku-buku kesehatan lainnya.

PROFIL PENULIS



Agustina, S.SiT., MKM

Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di STIKes Darussalam Lhokseumawe Aceh dan melanjutkan S2 di Program Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Aceh. Sejak 2014 penulis aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini beliau aktif mengajar di Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim Bireuen Aceh. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.

Email penulis agustina@umuslim.ac.id.



Ni Made Ayu Yulia Raswati Teja, S.Si.T., M.Kes

Penulis lahir di Denpasar, berasal dari Provinsi Bali. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan D III Kebidanan di Akademi Kebidanan An-Nur Purwodadi pada tahun 2007. Setelah lulus kuliah D III kebidanan penulis melanjutkan kuliah D IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo dan menyelesaikan kuliah pada tahun 2008. Setelah lulus D IV Kebidanan penulis bekerja di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Konsentrasi KIA_Kespro di Universitas Udayana Denpasar Bali dan telah lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis masih aktif sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali pada Program Studi Sarjana Kebidanan. Penulis juga aktif dalam penerbitan jurnal nasional terakreditasi.

Email penulis: ayuteja.stikesbali@gmail.com

PROFIL PENULIS



Lusi Afriyani, S.S.T.,M.Tr.Keb. adalah nama lengkapnya, ia lahir di Wonosobo pada tanggal 09 maret 1993. Dosen muda yang kini berusia 30 tahun sudah tertarik dengan ilmu kesehatan terkhusus kebidanan sejak masuk ke Universitas Adiwangsa Jambi ditahun 2011 dan kemudian melanjutkan studinya kembali di Politekkes Kemenkes Semarang. Kini ia bekerja disalah satu Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Jawa Timur. Sebelum ia menjadi dosen lusi melakukan perjalanan karirnya menjadi bidan kontrak disalah satu perusahaan sawit didaerah jambi, kemudian berlanjut menjadi guru di SMA kabupaten dimana lusi bertempat tinggal. Diluar pekerjaannya, ia lebih memilih menghabiskan waktu produktif dalam menulis dan publikasi hubungan masyarakat yang dimana sedang ia geluti sebagai bidang HUMAS di tempat kerjanya.

Dengan hobi menulisnya, lusi sudah menerbitkan 5 buku dibidang kesehatan yaitu kebidanan, seperti buku asuhan kebidanan, pengantar praktik kebidanan, fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL, Buku referensi KB dan pelayanan kontrasepsi berbasis bukti, dan buku tentang kepribadian seorang bidan. Serta lusi juga hobi dalam menulis artikel di web yang dikelolanya dengan nama web Lusi Afriyani. Selain menulis, anak pertama dari 2 bersaudara ini memiliki hobi treveling, memasak dan bernyanyi. Berkat hobinya ia sering memiliki banyak rekan dari berbagai tempat. Saat ini lusi sedang mengerjakan proyek yang berselogan “PeTuAH IBU”. Proyek tersebut terbentuk karena adanya peningkatan pernikahan dini dikalangan remaja serta keresahan tenaga kesehatan dengan dampak yang ditimbulkan. Berawal dari proyek inilah Lusi menemukan banyak definisi Asuhan Kebidanan Remaja yang menyeluruh.

Adanya proyek tersebut lusi sangat hobi menggeluti permasalahan yang ada di remaja dan saat ini ia juga sangat aktif dalam berbagai forum remaja yang ada di bojonegoro. Dengan demikian harapan lusi bisa menciptakan generasi penerus agar lebih produktif, energik dan semangat.

PROFIL PENULIS



Machria Rachman, S.ST., M.Kes

Penulis menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan di AKBID Yayasan RSI Surabaya tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan D-IV Kebidanan pada perguruan tinggi STIKes Insan Unggul Surabaya. Kemudian tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Promosi Kesehatan dengan Peminatan Kesehatan Reproduksi dan HIV-AIDS Universitas Diponegoro Semarang. Sejak tahun 2007 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan, dan saat ini penulis aktif melaksanakan kegiatan tridarma PT di STIKes Banyuwangi pada Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta publikasi penelitian pada jurnal nasional dan internasional lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui email machria@stikesbanyuwangi.ac.id

SINOPSIS

Asuhan Kebidanan Pada Remaja, penulis membahas masalah dan kebutuhan remaja yang mengacu pada berbasis bukti. Penulis mengupas kebutuhan fisiologis dan psikologis yang dibutuhkan remaja serta kebutuhannya.

Buku ini mengangkat isu stunting yang terjadi pada masa pertumbuhan sebelum remaja dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga skrining pubertas yang tepat perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Topik lainnya juga membahas tentang beberapa masalah dominan yang dialami remaja diantaranya adalah perubahan dan adaptasi psikologis dimana proses alamiah ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan menjadi salah satu penentu kesejahteraan remaja dalam proses tumbuh kembangnya. Masalah lain pada remaja yang dibahas pada buku ini adalah tentang perilaku seks pranikah, risiko yang akan dialami remaja salah satunya adalah kehamilan di usia muda dimana ini adalah faktor risiko terjadinya persalinan yang patologis dan juga bayi yang dilahirkan akan rentan menjadi anak yang stunting. Pembahasannya lainnya pada buku ini adalah tentang anemia, personal hygiene, dismenorea serta gerakan senam yang dapat meredakan nyeri yang dirasakan saat menstruasi. Kebutuhan remaja yang kompleks tersebut dapat dikaji dengan metode anamnesa HEEADSSS yang juga tercantum pada buku ini.

Topik pembahasan yang diangkat pada buku ini diambil dari masalah yang banyak muncul pada remaja dan oleh karena itu pada buku ini juga disertai dengan intervensi sebagai asuhan kebidanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan dan dapat diadaptasi juga oleh masyarakat awam setelah mendapatkan arahan yang tepat dari tenaga kesehatan. Intervensi yang dijelaskan mengacu pada hasil penelitian atau berbasis bukti sehingga penatalaksanaan yang diberikan dapat membantu remaja serta orang tua atau tenaga kesehatan dan masyarakat umum untuk dapat memberdayakan remaja dengan baik.

Asuhan Kebidanan Pada Remaja, penulis membahas masalah dan kebutuhan remaja yang mengacu pada berbasis bukti. Penulis mengupas kebutuhan fisiologis dan psikologis yang dibutuhkan remaja serta kebutuhannya.

Buku ini mengangkat isu stunting yang terjadi pada masa pertumbuhan sebelum remaja dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga skrining pubertas yang tepat perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Topik lainnya juga membahas tentang beberapa masalah dominan yang dialami remaja diantaranya adalah perubahan dan adaptasi psikologis dimana proses alamiah ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan menjadi salah satu penentu kesejahteraan remaja dalam proses tumbuh kembangnya. Masalah lain pada remaja yang dibahas pada buku ini adalah tentang perilaku seks pranikah, risiko yang akan dialami remaja salah satunya adalah kehamilan di usia muda dimana ini adalah faktor risiko terjadinya persalinan yang patologis dan juga bayi yang dilahirkan akan rentan menjadi anak yang stunting. Pembahasannya lainnya pada buku ini adalah tentang anemia, personal hygiene, dismenorea serta gerakan senam yang dapat meredakan nyeri yang dirasakan saat menstruasi. Kebutuhan remaja yang kompleks tersebut dapat dikaji dengan metode anamnesa HEEADSSS yang juga tercantum pada buku ini.

Topik pembahasan yang diangkat pada buku ini diambil dari masalah yang banyak muncul pada remaja dan oleh karena itu pada buku ini juga disertai dengan intervensi sebagai asuhan kebidanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan dan dapat diadaptasi juga oleh masyarakat awam setelah mendapatkan arahan yang tepat dari tenaga kesehatan. Intervensi yang dijelaskan mengacu pada hasil penelitian atau berbasis bukti sehingga penatalaksanaan yang diberikan dapat membantu remaja serta orang tua atau tenaga kesehatan dan masyarakat umum untuk dapat memberdayakan remaja dengan baik.

Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919



Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

ISBN 978-623-88659-2-5



9 786238 865925

